Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Pautas de cuidado basadas en la evidencia para el abordaje integral de la salud de cuidadores en la familia y en el entorno hogar.

Gobernación de Boyacá | Salud

Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Yaneth Manrique Abril

Secretaria de salud

Candy Samanta Rodríguez Castillo

Directora de Promoción y Prevención

Martín Orlando Barrera Cobos

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Blanca Nubia Vásquez

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Grupo Desarrollador

Lorena Mesa Melgarejo

Enfermera, Magister en Salud Pública, Máster en Economía de la Salud y Doctora en Salud Pública. Secretaria de Salud de Boyacá

Liseth Matamoros Parra

Médica Especialista. Docente Programa de Especialidad Medicina Familiar y comunitaria. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Solanye Galindo Huertas

Enfermera. Magister y Doctora en estudios Sociales. Docente Escuela de Enfermería UPTC

Ruth Alexandra Castiblanco

Enfermera. Magister en salud pública. Magister en epidemiología. Docente investigadora. Universidad Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS

Liliana Marcela Reina

Enfermera. Magister y Doctora en enfermería. Docente investigadora. Universidad Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS

Expertas y expertos participantes

Yaneth Efigenia Peña

Profesional Universitario. Referente programa de discapacidad. Subdirección de promoción social en salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Martín Barrera

Profesional Universitario. Dirección de promoción de la salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Adriana Gabriela Cortes Zambrano

Equipo de profesionales programa de discapacidad. Subdirección de promoción social en salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Elisa Jimena González Castañeda

Equipo de profesionales programa de discapacidad. Subdirección de promoción social en salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Bety Julieth Florian Rojas

Equipo de profesionales programa de discapacidad. Subdirección de promoción social en salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Zulma Liceth Lancheros Castiblanco

Equipo de profesionales programa de discapacidad. Subdirección de promoción social en salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Paula Andrea Reyes Fernández

Equipo de profesionales programa de discapacidad. Subdirección de promoción social en salud. Secretaria de salud de Boyacá.

Declaración de conflictos de intereses:

Las personas que participaron en la elaboración, revisión y validación de las presentes Pautas de cuidado basadas en la evidencia fueron invitadas a declarar sus intereses financieros, profesionales, académicos, institucionales y personales que pudieran influir, o percibirse como susceptibles de influir, en el desarrollo de los contenidos y la formulación de las recomendaciones. No se identificaron conflictos de intereses que comprometieran la independencia técnica del proceso de elaboración de este documento.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial:

La herramienta Claude de Antropic fue utilizada en el presente documento para el proceso de extracción de datos de los textos completos seleccionados en las matrices de síntesis de la información. Su utilización fue complementaria al trabajo del equipo responsable y no sustituyó los procedimientos de búsqueda, selección, análisis crítico e interpretación de la evidencia científica, ni los procesos de deliberación y formulación de las pautas de cuidado. La responsabilidad por la rigurosidad metodológica, la pertinencia de las recomendaciones, la integridad de la información y el contenido final del documento corresponde exclusivamente al equipo humano responsable de su elaboración.

Contenido

1. Introducción 8
1.1 Enfoque de reconocimiento y corresponsabilidad del cuidado: marco de las 5R 9
2. Objetivos 10
2.1 General 10
2.2 Específicos 10
3. Alcance 11
Población objetivo 11
Usuarios 11
Contexto 11
Aspectos abordados 11
Aspectos no abordados 11
4. Contexto territorial de la condición de salud 12
4.1 Dimensión epidemiológica 12
4.2 Dimensión clínica 12
4.3 Dimensión de contexto y determinantes 13
- Adherencia 13
5. Marco normativo 14
6. Preguntas orientadoras 17
7. Metodología 17
7.1 Priorización de temas 17
7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras. 18
7.3 Búsqueda y selección de la evidencia. 18
7.4 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia. 19
7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión. 20
8. Resultados: Síntesis narrativa de la evidencia 20
8.1 Pregunta 1. 20
8.2 Pregunta 2 32
8.3 Pregunta 3 38
8.4 Pregunta 4. 46

9. Pautas de cuidado preliminares para el abordaje integral del cuidador familiar o informal en el entorno hogar. 51

9.1 Generales 51

9.2 Pautas pregunta 1. Identificación del rol cuidador, valoración de la sobrecarga y clasificación del riesgo 53

- Identificación proactiva del rol cuidador 53
- Tamizaje y medición de la sobrecarga 54
- Clasificación y seguimiento 56

9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones estructuradas para proteger la salud del cuidador y favorecer la sostenibilidad del cuidado 57

- Intervenciones psicológicas y psicosociales. 58
- Intervenciones de enfermería y proximidad. 59
- Actividad física y autocuidado. 59
- Modalidades remotas. 60
- Adaptación a condiciones clínicas. 60
- Evaluación de resultados. 61

9.4 Pautas pregunta 3. Componente A. Identificación y estratificación del riesgo clínico, psicosocial y de seguridad. 61

- Evaluación de la complejidad de la persona cuidada 62
- Evaluación psicosocial y estructural del rol 62
- Evaluación clínica de la persona que cuida 63
- Riesgo de violencia y seguridad 63
- Estratificación operativa 64

9.5 Componente B. Respuesta y activación intersectorial según el nivel de riesgo 65

- Respuesta para riesgo bajo 66
- Respuesta para riesgo moderado 66
- Respuesta para riesgo alto 67
- Respuesta para riesgo crítico o de seguridad 67
- Mecanismos de articulación 68

9.6 Pauta Pregunta 4. Estrategias de educación y apoyo para fortalecer la preparación, autoeficacia y competencia del cuidador ... 70

- Valoración educativa inicial 70
- Contenidos esenciales 70

- Métodos educativos 71
- Modalidades digitales, telefónicas y grupales 72
- Transiciones y continuidad 73
- Evaluación de la intervención educativa 74

10. Referencias 74
11. Anexos 81

11.1 Ecuaciones de búsqueda 81

1. Introducción

En Boyacá, el abordaje de la salud del cuidador familiar se ha convertido en una prioridad sanitaria y social por la transición demográfica y el aumento de hogares con dependencia y cronicidad. El ASIS 2024 describe un envejecimiento progresivo, dónde la población de adultez y vejez crece de forma lineal y el índice de dependencia de mayores de 65 años aumenta (de 18 en 2019 a 20 en 2024, con proyección a 22 en 2029), lo que incrementa la presión sobre familias y redes de cuidado(1) .En el mismo sentido, el ASIS 2023 muestra que la proporción de personas mayores (60+) pasó de 14,5% (2015) a 17,6% (2023) y continúa en ascenso, reforzando el escenario de multimorbilidad, deterioro funcional y necesidad de cuidados de larga duración en el entorno hogar (2).

La evidencia científica indica que el cuidado informal sostenido se asocia con una alta carga física y emocional para los cuidadores, incluyendo sobrecarga, ansiedad y depresión, con efectos sobre la salud del cuidador y sobre la continuidad y calidad del cuidado brindado. Una revisión paraguas reciente reporta prevalencias medianas elevadas en cuidadores informales: alrededor de 33% para depresión, 35% para ansiedad y cerca de 49% para carga/sobrecarga, lo que dimensiona el problema como un asunto clínicamente relevante y no solo social. Adicionalmente, guías internacionales para personas mayores con múltiples condiciones crónicas enfatizan que los sistemas deben identificar cuidadores y considerar/valorar sus necesidades, promoviendo apoyos comunitarios y articulación sociosanitaria, porque el aislamiento social y la progresión de las condiciones aumentan la complejidad del cuidado y el riesgo de "agotamiento" del cuidador.

En Boyacá, este problema no ocurre en el vacío, pues se expresa en un contexto de presiones socioeconómicas que afectan la sostenibilidad del cuidado. Los reportes del PICF/SIBACOM muestran indicadores de dependencia económica por subred, evidenciando mayor presión sobre la población en edad productiva para sostener a menores de 15 y mayores de 65 años; por ejemplo, en junio se identifican valores críticos en subredes como la 5 (93) y la 9 (83), y se relaciona este patrón con la tendencia de envejecimiento descrita por el ASIS 2024. En paralelo, SIBACOM evidencia que el componente de "cuidado del cuidador" está siendo movilizado de manera notable, en el LT4 (modifica y adopta prácticas de cuidado) y en el LT6 (inclusión social, familiar, educativa y comunitaria), con incrementos importantes en compromisos y en cumplimiento (verde), llegando hasta 1.193 compromisos en julio para LT6(3).

En este marco, una herramienta basada en evidencia para "Familia con integrante que requiere abordaje integral de la salud del cuidador familiar en hogares con dependencia o cronicidad" puede ayudar a reducir la variabilidad en la práctica, fortalecer la agencia de cuidado familiar y asegurar que el cuidador sea reconocido como sujeto de cuidado dentro del PICF(4). Este documento basado en la evidencia permitirá definir criterios homogéneos para: identificación temprana de sobrecarga y riesgos (físicos, emocionales y sociales), intervenciones factibles en el entorno hogar (educación, autocuidado, corresponsabilidad, apoyo psicosocial, articulación con oferta comunitaria), y rutas de remisión y seguimiento según nivel de complejidad, con trazabilidad mediante los logros trazadores del SIBACOM.

1.1 Enfoque de reconocimiento y corresponsabilidad del cuidado: marco de las 5R

El abordaje del cuidado familiar parte de reconocer que cuidar es una actividad indispensable para el sostenimiento de la vida, pero su distribución no es socialmente neutra. La evidencia regional y nacional muestra que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado continúa concentrándose de manera desproporcionada en las mujeres, con efectos sobre su autonomía económica, participación laboral, uso del tiempo, bienestar y oportunidades de desarrollo(5) . En Colombia, la Política Nacional de Cuidado reconoce expresamente que la organización social del cuidado es inequitativa y que esta desigualdad limita el ejercicio efectivo de derechos de las personas cuidadoras. Asimismo, reporta que, entre las personas cuidadoras no remuneradas de tiempo completo, las mujeres representan el 85,7 %, lo que confirma el carácter marcadamente feminizado del cuidado (6).

Como marco orientador, estas pautas adoptan las 5R para el trabajo de cuidados decente propuestas por la Organización Internacional del Trabajo: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, y recompensar y garantizar la representación de quienes realizan trabajo de cuidado remunerado. Este enfoque propone hacer visible y valorar el cuidado; reducir las cargas evitables mediante servicios, infraestructura, formación, tecnologías y apoyos; y redistribuir las responsabilidades entre mujeres y hombres, los hogares, la comunidad, el Estado y otros actores sociales. Asimismo, plantea que quienes realizan trabajo de cuidado deben contar con condiciones dignas, protección social, voz y participación en las decisiones que afectan la organización del cuidado (5,7). Este marco es coherente con la perspectiva de la CEPAL sobre la sociedad del cuidado, que plantea

avanzar desde arreglos familistas y feminizados hacia sistemas de corresponsabilidad social y de género que reconozcan el cuidado como necesidad, derecho y función social indispensable (8) .

Desde esta perspectiva, las pautas de cuidado no buscan únicamente aumentar la capacidad de la mujer cuidadora para soportar o desempeñar mejor una carga ya existente, sino identificar qué responsabilidades pueden ser reconocidas, reducidas, redistribuidas o apoyadas. La valoración del cuidador debe, por tanto, considerar no solo sus conocimientos y competencias, sino también el tiempo dedicado al cuidado, las renuncias laborales o personales, la disponibilidad de relevo, la distribución intrafamiliar de las tareas y el acceso efectivo a apoyos institucionales y comunitarios. El fortalecimiento de capacidades debe acompañarse de acciones que protejan la autonomía, la salud y el proyecto de vida de quien cuida, reconociendo a las mujeres cuidadoras como sujetos de derechos y no únicamente como proveedoras naturales de cuidado. Esta orientación coincide con la Política Nacional de Cuidado de Colombia, que plantea transformar la organización social del cuidado mediante corresponsabilidad entre Estado, sociedad, comunidad y hogares (6)

2. Objetivos

2.1 General

Generar orientaciones basadas en la evidencia que facilite la acción de los equipos interdisciplinares de salud que implementan Plan Integral de Cuidado Familiar (PICF) para el cuidado a la cuidadora y el cuidador en el entorno hogar.

2.2 Específicos

- ✓ Definir y estandarizar los criterios operativos para identificar al cuidador principal en el entorno hogar y caracterizar su adopción del rol, valorar sus dimensiones física y de salud mental y la identificación de sobrecarga.
- ✓ Establecer las intervenciones integrales basadas en evidencia, factibles en el entorno hogar, para proteger y fortalecer la salud del cuidador (enfoque del cuidado de sí).

- ✓ Precisar los criterios de alarma y activación de rutas ante situaciones de riesgo y sobrecarga de la persona que cuidada en el entorno hogar, articulando respuestas desde salud y sociales para garantizar continuidad del cuidado y reducir desenlaces evitables.
- ✓ Identificar estrategias basadas en la evidencia para facilitar el rol de la persona que cuida en el entorno hogar.

3. Alcance

Población objetivo

Persona identificada como cuidadora en la familia y el entorno hogar.

Usuarios

Equipos básicos de salud que realizan implementación del plan integral de cuidado familiar.

Contexto

Entorno hogar, con identificación de la persona que cuida, su sobrecarga, riesgos físicos/mentales de la persona que cuida y plan de cuidado del cuidador integrado al plan familiar

Aspectos abordados

- ✓ Detección de sobrecarga, estrés, depresión/ansiedad, trastornos del sueño, dolor, aislamiento, violencia o conflicto.
- ✓ Competencias del cuidador: técnicas básicas de cuidado seguro, autocuidado, redes de apoyo, pausas.
- ✓ Criterios de priorización y derivación (salud mental, respiro, rehabilitación, apoyo social).
- ✓ Educación y estrategias de apoyo a la persona que cuida.

Aspectos no abordados

Tratamiento especializado de trastornos psiquiátricos graves; no reemplaza rutas vigentes

4. Contexto territorial de la condición de salud

4.1 Dimensión epidemiológica

En Boyacá, la cronicidad y la dependencia se explican, en gran medida, por una transición demográfica avanzada hacia el envejecimiento. El ASIS 2024 documenta crecimiento sostenido de los cursos de vida de adultez y vejez y un aumento del índice de dependencia de mayores de 65 años (de 18 en 2019 a 20 en 2024; proyección 22 en 2029), lo que incrementa la proporción de hogares que requieren cuidados de larga duración y apoyo cotidiano en el entorno hogar(1) . En términos de sostenibilidad socioeconómica, los reportes del PICF/SIBACOM muestran un indicador de dependencia económica que expresa la presión sobre las personas en edad productiva (15–64) para sostener a menores de 15 y mayores de 65 años: en junio, la Subred 5 alcanzó un nivel crítico de 93 y la Subred 9 valores alrededor de 83–84, manteniéndose entre las más altas en julio (3) . Este contexto es coherente con un escenario donde la cronicidad y la dependencia no son fenómenos aislados, sino problemas estructurales que tensionan a las familias (tiempo, ingresos, cuidado, transporte y acceso) y que requieren estandarización de apoyos desde el PICF.

4.2 Dimensión clínica

Para el lineamiento, es útil asumir definiciones operativas:

- Cronicidad: condiciones de curso prolongado que exigen seguimiento continuo, autocuidado y soporte familiar (p. ej., demencias, enfermedad cerebrovascular, secuelas neurológicas, multimorbilidad, fragilidad).
- Dependencia: necesidad de ayuda de terceros para realizar actividades de la vida diaria (AVD/ADL) y/o actividades instrumentales (AIVD/IADL), con distintos niveles de severidad.
- Sobrecarga del cuidador: experiencia multidimensional (emocional, física, social y financiera) derivada de las demandas del cuidado que puede deteriorar la salud del cuidador y su capacidad de sostener el rol. Esta definición coincide con descriptores usados por instrumentos ampliamente empleados como el Zarit Burden Interview(9) , donde la "carga" se entiende como consecuencias percibidas en salud física, vida social y situación financiera, entre otras.

La evidencia científica confirma que la sobrecarga es frecuente y clínicamente relevante, una revisión paraguas reciente reporta prevalencias medianas elevadas en cuidadores informales, alrededor de 33% para depresión, 35% para ansiedad y aproximadamente 49% para carga/sobrecarga, lo que dimensiona el problema como un asunto de salud pública y no solo social (10) . En Boyacá, el ASIS 2024 reconoce explícitamente este fenómeno en el marco de salud mental: describe agotamiento y "burnout del cuidador" en quienes rodean a personas con salud mental y demencias, asociado a estrés y a la falta de recursos sociales/comunitarios (por ejemplo, formación socioemocional y programas de respiro)(1,2).

4.3 Dimensión de contexto y determinantes

El comportamiento de la dependencia y la sobrecarga del cuidador puede ser visto como un fenómeno familiar y sistémico, en la medida en que la carga de cuidado se distribuye (o concentra) dentro del hogar, en interacción con barreras económicas, redes de apoyo limitadas, y oferta insuficiente de servicios. En Boyacá, el ASIS 2024 señala que la oferta de servicios de salud mental es insuficiente y poco resolutiva en el nivel primario, con concentración de oferta (62% en zona centro) y fragmentación, lo que limita la respuesta a necesidades frecuentes en cuidadores (ansiedad, depresión, estrés, duelo, agotamiento)(1) . Esta insuficiencia se combina con la carga de dependencia económica por subred reportada por SIBACOM, lo que sugiere que, en territorios con mayor presión al competir directamente con empleo, ingresos y tiempo disponible, elevando riesgo de deterioro del cuidador y del plan de cuidado del hogar (3) . En consecuencia, el lineamiento debe asumir que el riesgo del cuidador no depende solo de "motivación", sino de condiciones de contexto.

- Adherencia

En este lineamiento, "adherencia" debe comprenderse en sentido amplio: no solo adherencia farmacológica del integrante dependiente, sino adherencia del hogar al plan de cuidado (prácticas de cuidado seguro, seguimiento, uso de apoyos, autocuidado del cuidador y acceso oportuno a servicios). La OMS define adherencia como el grado en que el comportamiento (medicación, dieta y/o cambios de estilo de vida) corresponde con recomendaciones acordadas con un proveedor de salud, subrayando que es un fenómeno influido por múltiples factores (persona, tratamiento, sistema, contexto). En el PICF/SIBACOM, este concepto se

operacionaliza mediante logros trazadores del componente "cuidado del cuidador". En julio, se observa un avance importante en el LT4: "Modifica y adopta prácticas de cuidado": el reporte indica que entre junio y julio aumentaron los compromisos y mejoró el cumplimiento (verde), lo que sugiere mayor adopción de prácticas educativas y preventivas por cuidadores. De forma complementaria, el LT6: "Inclusión social, familiar, educativa y comunitaria" muestra incremento de compromisos y cumplimiento, alcanzando hasta 1.193 compromisos en verde en julio, lo que es relevante porque la evidencia asocia redes de apoyo a sobrecarga y mejor sostenibilidad del cuidado. Sin embargo, estos indicadores capturan principalmente "compromisos y cumplimiento" y no necesariamente miden de forma directa la sobrecarga clínica (depresión, ansiedad, agotamiento).

En términos generales, Boyacá presenta un contexto demográfico y socioeconómico que incrementa hogares con cronicidad y dependencia, con señales explícitas de agotamiento/burnout del cuidador en el ASIS y con capacidad operativa de seguimiento mediante logros trazadores del PICF/SIBACOM. Esto justifica que la herramienta estandarice: identificación del cuidador y su riesgo, intervenciones familiares y comunitarias, rutas de apoyo/respiro, y un monitoreo que complemente compromisos del SIBACOM con medición clínica de sobrecarga y salud mental del cuidador.

5. Marco normativo

El desarrollo del presente documento tiene en consideración el marco normativo nacional y territorial vigente y en particular las siguientes normas aplicables:

Tabla 1. Normativa aplicable a la herramienta

Norma	Aspecto relevante para el cuidado al cuidador
Ley 1251 de 2008	Establece normas para la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas mayores y reconoce responsabilidades concurrentes del Estado, la sociedad civil y la familia. Es pertinente cuando el cuidado recae sobre personas mayores dependientes y para orientar medidas de apoyo familiar.
Ley 1346 de 2009	Aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Establece como referentes la autonomía, dignidad, participación, inclusión, no discriminación y ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad, marco indispensable para evitar que el abordaje del cuidador sustituya la autonomía de la persona cuidada.

Ley 1361 de 2009, modificada por la Ley 1857 de 2017	Ley de Protección Integral a la Familia. Reconoce a la familia como sujeto de protección y establece medidas para fortalecer sus recursos. La Ley 1857 incorpora medidas de conciliación entre responsabilidades familiares y laborales, incluyendo la posibilidad de horarios flexibles para acompañar familiares mayores, con discapacidad o dependencia.
Ley 1413 de 2010	Reconoce y mide el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como contribución económica y social. Incluye expresamente el cuidado de personas mayores y enfermas. Aporta el marco para reconocer que el cuidado familiar es trabajo y no una obligación invisible o ilimitada de la familia, especialmente de las mujeres.
Ordenanza 023 de 2010 del departamento de Boyacá	Adopta el modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario en Boyacá, dentro del cual se desarrolla el Plan Integral de Cuidado Familiar. Constituye el referente territorial directo para la identificación de necesidades, fortalezas, prácticas de cuidado y recursos familiares en el entorno hogar.
Ley 1438 de 2011	Fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la estrategia de Atención Primaria en Salud, con énfasis en atención integral, integrada y continua, coordinación intersectorial y actuación sobre familias y comunidades. Es fundamento del abordaje territorial y familiar del cuidador.
Ley Estatutaria 1618 de 2013	Establece disposiciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad mediante inclusión, ajustes razonables y eliminación de barreras. Es referente para el trabajo con familias, cuidadores y para la implementación de estrategias como Rehabilitación Basada en Comunidad.
Ley 1616 de 2013, modificada por la Ley 2460 de 2025, y Decreto 729 de 2025	Conforman parte del marco vigente de salud mental. La Ley 2460 amplía las disposiciones para promoción y cuidado de la salud mental y prevención y atención integral de trastornos mentales. Resulta directamente aplicable cuando en la valoración del cuidador se identifican depresión, ansiedad, distrés, crisis o riesgo para la salud mental.
Ley Estatutaria 1751 de 2015	Regula el derecho fundamental a la salud y exige atención integral, oportuna y sin discriminación. Sustenta que el cuidador debe ser reconocido también como sujeto de atención en salud y no solamente como recurso para atender a la persona dependiente.
Resolución 3280 de 2018	Adopta las Rutas Integrales de Atención para Promoción y Mantenimiento de la Salud y Materno Perinatal. Reconoce la educación individual, familiar y colectiva y orienta intervenciones en el entorno hogar.
Ley 1996 de 2019 y Decreto 487 de 2022	Garantizan la capacidad legal plena de las personas adultas con discapacidad y regulan los apoyos para la toma de decisiones. Son relevantes para diferenciar entre cuidar o apoyar y sustituir indebidamente la

	voluntad de la persona con discapacidad, y para reconocer y valorar las redes de apoyo.
Ley 2126 de 2021, en articulación con Ley 1257 de 2008 y demás normas sobre violencia intrafamiliar	Regula las Comisarías de Familia y la respuesta frente a violencias en el contexto familiar. Incluye expresamente situaciones en las que participan personas encargadas del cuidado y establece medidas de protección, atención y estabilización. Es el soporte normativo para la activación de rutas cuando durante el cuidado se identifique violencia, abuso, amenaza, negligencia o riesgo de seguridad.
Ley 2297 de 2023	Norma particularmente relevante para cuidadores de personas con discapacidad. Establece medidas para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad y reconoce a cuidadores y asistentes personales, incluyendo acciones relacionadas con formación, empleo, generación de ingresos, caracterización y atención en salud.
CONPES 4143 de 2025, Política Nacional de Cuidado	Instrumento de política pública, no ley. Plantea una transformación de la organización social del cuidado bajo principios de corresponsabilidad, autonomía, participación y reconocimiento de los derechos a cuidar, recibir cuidado y ejercer autocuidado. Es especialmente pertinente para fundamentar la redistribución del cuidado y evitar su concentración en una sola persona.
Ley 2456 de 2025	Crea los Fondos de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores o Asistentes Personales. Contempla recursos para programas de salud mental y física de cuidadores, formación y cualificación, mejoramiento de calidad de vida, inclusión y caracterización/certificación de cuidadores. Es una de las normas más directamente relacionadas con "cuidado al cuidador".
Ley 2466 de 2025	Incorpora medidas laborales para personas con responsabilidades de cuidado. Permite acordar jornadas o modalidades flexibles para trabajadores que cuidan personas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, catastróficas o terminales, y modifica la Ley 2297 respecto de flexibilidad laboral para cuidadores de personas con discapacidad.
Resolución 1597 de 2025, modificada por la Resolución 1801 de 2026	Regula la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública y el PIC en el marco del PDSP y la APS. Sitúa el cuidado integral de la salud como proceso ordenador y fortalece la coordinación intersectorial, la participación social y comunitaria y las intervenciones territorializadas, marco operativo directo para desarrollar las pautas de cuidado al cuidador desde el PICF.

Fuente: elaboración propia.

6. Preguntas orientadoras

- ¿Qué estrategias e instrumentos validados se usan para identificar la sobrecarga del cuidador y riesgos del cuidador en el entorno hogar y clasificarlos para decidir intensidad de acompañamiento?
- En cuidadores familiares de personas ¿qué intervenciones estructuradas dirigidas al cuidador, mejoran su salud y favorecen la sostenibilidad del cuidado en el entorno hogar?
- En cuidadores familiares o informales de personas con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿cuáles son los signos de alarma y los criterios de riesgo clínico, psicosocial y de seguridad que permiten identificar el deterioro de la salud física o mental, la violencia y el colapso del rol cuidador, y qué respuestas intersectoriales escalonadas deben activarse, según el nivel de riesgo, para proteger al cuidador y sostener el cuidado en casa?
- En cuidadores familiares o informales de personas con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿qué estrategias estructuradas de educación y apoyo dirigidas al cuidador incrementan la preparación, la autoeficacia y la competencia para ejercer el rol cuidador, y de qué manera contribuyen a la sostenibilidad del cuidado en casa?

7. Metodología

El desarrollo de esta herramienta se basa en el Manual para el desarrollo de lineamientos técnicos basados en evidencia del IETS (primera edición, 2024) y en el objetivo de consolidar y difundir acciones/indicaciones basadas en la mejor evidencia disponible e integrando experiencia experta y contexto territorial. Así, la metodología se organizó en cuatro momentos: 1. Priorización de temáticas; 2. validación de preguntas con equipo AT-PIC y referentes; 3. búsqueda y selección sistemática de evidencia y síntesis, y 4. construcción de pautas/lineamientos con consenso informal.

7.1 Priorización de temas

El proceso de priorización de temáticas para desarrollar cinco herramientas basadas en evidencia en el marco del PICF inició con una identificación preliminar de problemáticas mediante triangulación de fuentes (seguimiento PICF, cruce con núcleos/respuestas del Plan Territorial de Salud y ASIS), delimitando desde el inicio temas con alta posibilidad de intervención directa por los equipos básicos (acciones

clínicas, seguimiento familiar, educación, detección temprana y articulación con RIAS) y excluyendo determinantes estructurales cuyo abordaje principal no es sanitario. Posteriormente, se aplicó una priorización multicriterio con cinco criterios explícitos (magnitud, severidad, inequidad, factibilidad y alineación), con ponderaciones sugeridas (25%, 20%, 20%, 25% y 10%, respectivamente) y un esquema de votación 1–5 con reglas de inclusión/exclusión por acuerdo ≥80%, utilizando una técnica tipo Delphi con calificación ciega por expertas/os.

La priorización se realizó en dos rondas con dos grupos: primero el equipo de Asistencia Técnica del PIC (ronda 1) y luego el equipo de Promoción y Prevención (ronda 2), incorporando además temáticas nuevas sugeridas al final del cuestionario para ser consideradas en la segunda ronda. Finalmente, tras comparar resultados de la segunda ronda, se definieron las cinco temáticas seleccionadas para la vigencia: (i) riesgo cardiovascular familiar, (ii) consumo de riesgo y problemático de alcohol, (iii) salud del cuidador en hogares con dependencia/cronicidad, (iv) valoración y cuidado integral de la persona mayor (vejez) y (v) cuidados en el hogar para familias con recién nacidos y mujeres en posparto.

7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras.

A partir de la triangulación de fuentes sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos y de interacción con algunos equipos de salud, se construyeron las preguntas orientadoras, las cuales se socializaron y validación con el equipo y referentes por medio de sesiones deliberativas. Este proceso sigue el modelo de lineamientos que contempla reuniones para discutir, ajustar y consensuar alcance y preguntas.

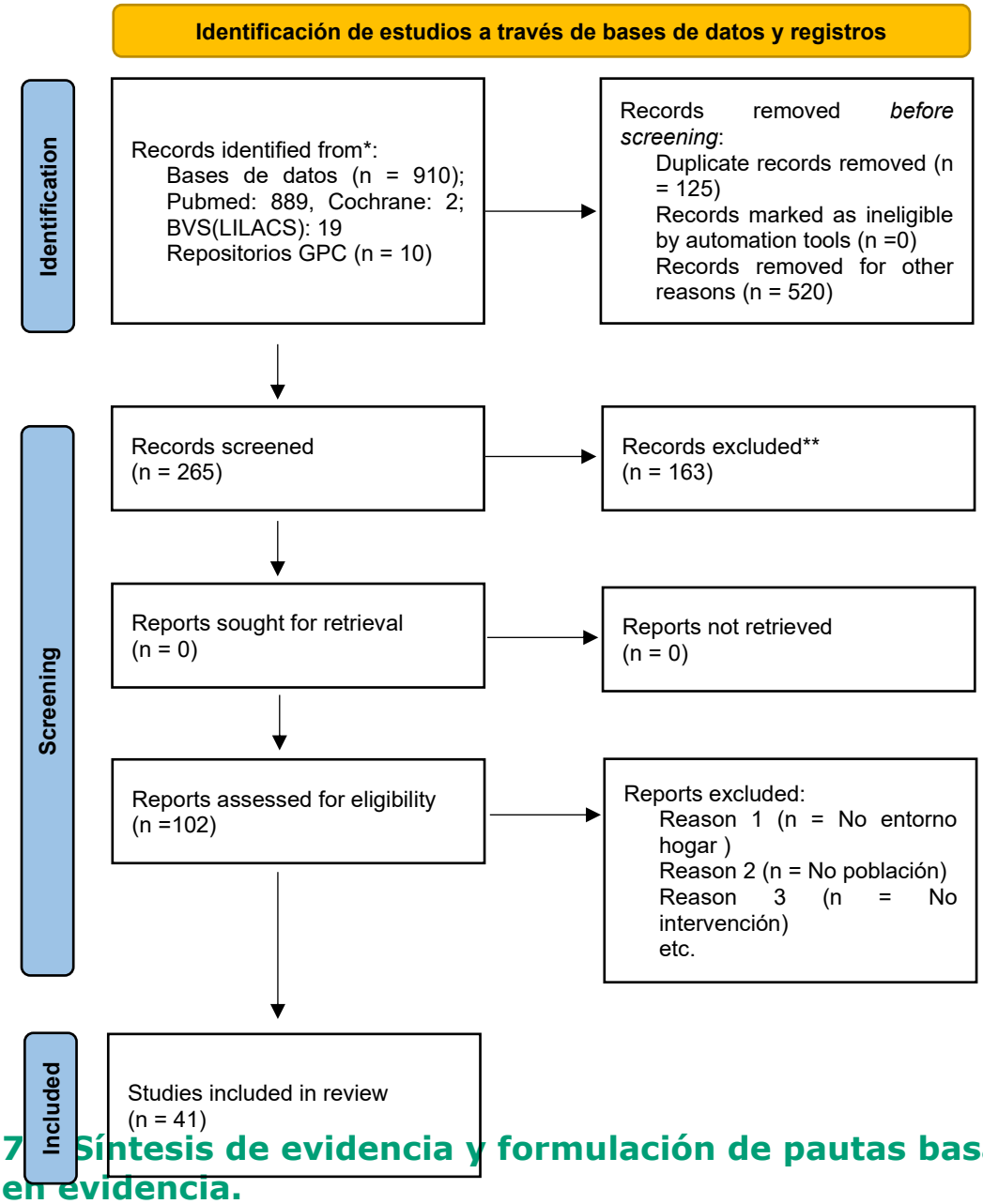
7.3 Búsqueda y selección de la evidencia.

Para responder a cada pregunta, se realizó una búsqueda sistemática estructurando ecuaciones de búsqueda a partir de términos indexados. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: MEDLINE, EMBASE, Cochrane y LILACS, complementada con literatura gris mediante Google Académico.

La estrategia incluyó (i) una búsqueda para identificar Guías de Práctica Clínica (GPC) recientes y (ii) una búsqueda para identificar revisiones

sistemáticas, con búsquedas independientes por pregunta cuando fue necesario. Los criterios de inclusión fueron: evidencia aplicable al entorno hogar, acorde con la población objeto, revisiones sistemáticas de literatura, guías de práctica clínica, consensos basados en la evidencia, publicaciones en inglés o español, sin límite de idioma. Las RSL se verificaron con la lista de chequeo AMSTAR; AGREE para el caso de las GPC, y ACCORD para el caso de los consensos.

A continuación, se presenta el PRISMA de la búsqueda:



7. Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia.

La evidencia incluida se resumió en aspectos clave para las intervenciones recomendadas en el entorno hogar para cada pregunta (beneficios/daños, desempeño de instrumentos de estratificación, factibilidad, recursos, equidad, aceptabilidad) y elaborando tablas de apoyo de dicha síntesis. Con base en esto y en la experiencia del equipo clínico y territorial, se elaboraron pautas preliminares que posteriormente se sometieron a discusión y consenso por parte del grupo de referentes de la secretaria de salud del departamento.

7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión.

Las pautas preliminares se discutieron rondas sincrónicas y asincrónicas con tres tipos de actores: 1. Expertas familiaristas vinculadas al proceso de implementación de las unidades de análisis del PIC. 2. Referentes de la secretaria de salud de Boyacá, 3. Equipos territoriales, buscando asegurar pertinencia territorial y aplicabilidad en el entorno hogar y 4. Equipo de docentes de la especialidad de medicina familiar de la U.P.T.C La aprobación de cada pauta se realizó mediante deliberación y acuerdo informal.

8. Resultados: Síntesis narrativa de la evidencia

8.1 Pregunta 1.

¿Qué estrategias e instrumentos validados se utilizan para identificar la sobrecarga del rol de cuidado y los riesgos del cuidador en el entorno hogar, y para clasificarlos con el fin de decidir la intensidad del acompañamiento?

Síntesis de evidencia

La evidencia disponible apoya una estrategia escalonada que permita: primero una identificación proactiva del cuidador mediante preguntas breves o checklist; después un tamizaje breve o estándar de sobrecarga; y, cuando haya señales de complejidad, una valoración multidimensional que incluya estado emocional, tiempo/intensidad de cuidado, dependencia de la persona cuidada, apoyo social y red disponible (2–4).

Un hallazgo muy consistente es que muchos cuidadores no se reconocen tempranamente como tales y, por eso, no buscan ayuda. La revisión sobre

atención primaria muestra que la identificación precoz sigue siendo difícil, y que incluso cuando existen instrumentos validados, estos se usan poco como tamizaje rutinario (5). Por eso, la estrategia más respaldada no es esperar a que el cuidador "se declare", sino buscarlo activamente en la visita o en el primer contacto: preguntar quién cuida, cuánto tiempo dedica, si releva a alguien, si ha cambiado su vida cotidiana y si cuenta con apoyos(5,6).

En esa línea, el artículo de Riffin desarrolla una lista de verificación para cuidadores (caregiver checklist) para atención primaria. No es una escala clásica de sobrecarga, sino una herramienta pragmática para identificar necesidades y preocupaciones del cuidador en tiempo real. Su valor no está en producir un puntaje de carga, sino en abrir una valoración estructurada, breve y útil para la acción(5). Además, fue construido desde un marco multidimensional que incluye contexto del cuidado, estado funcional del receptor, capacidades/preferencias del cuidador y apoyos disponibles (5).

En la misma línea, la revisión integrativa de Domeisen et al se identificaron 45 instrumentos de autoevaluación y analizó en detalle 9 que reunían los elementos más útiles para la práctica familiar y comunitaria. Su aporte central es que las herramientas más valiosas son aquellas que no se limitan a "medir carga", sino que ayudan a identificar rol, actividades de cuidado, necesidades, fortalezas y riesgos socioeconómicos, físicos y psicológicos, para orientar el apoyo individualizado (6).

Dentro de los instrumentos con mejor respaldo en la evidencia científica se encuentran:

1. Zarit Burden Interview, ZBI

Es el instrumento más utilizado. La literatura sobre demencia y cuidado crónico la recomienda, junto con otros tres, por su validez, confiabilidad, factibilidad y capacidad para recoger dimensiones subjetivas y objetivas de la carga. La versión de 22 ítems tarda menos de 10 minutos y tiene múltiples validaciones y versiones abreviadas, lo que favorece el uso en terreno o tamizaje rápido. Su limitación es que tiende a resumir la carga en un puntaje global y puede ser menos sensible para distinguir perfiles específicos o cambios finos en el tiempo (2–4).

2. Burden Scale for Family Caregivers, BSFC

Tiene versión larga de 28 ítems y corta de 10 ítems. La revisión en atención primaria la muestra como una herramienta fácil de entender, utilizable de forma independiente por el cuidador y útil para seguimiento repetido. Parece especialmente atractiva cuando se quiere una escala

breve, familiar y operativamente sencilla. Su principal limitación es que es menos multidimensional que otras (2,4).

3. Screen for Caregiver Burden, SCB

Es una opción fuerte cuando se requiere una lectura más diferenciada de la carga. La revisión de demencia muestra que el SCB tiene versión de 25 ítems y una versión corta de 7 ítems, con buena consistencia interna y dominios que separan problemas del paciente y efectos en el cuidador. Esto le da más capacidad para orientar intervenciones focalizadas. Su limitación es que surgió en el contexto de demencia/esposos cuidadores(4).

4. Caregiver Burden Inventory, CBI

Es probablemente la mejor opción cuando interesa perfilar la carga por dimensiones. La revisión reporta buena confiabilidad y cinco factores: emocional/psicológico, dependencia del tiempo, físico, evolutivo y social. Esto es valioso para decidir intensidad de acompañamiento porque no solo dice "hay mucha carga", sino en qué está la carga (4)

5. Instrumentos complementarios para necesidades y reacciones del cuidador

La revisión integrativa más amplia también incluye herramientas como CRA (Caregiver Reaction Assessment), CSI (Caregiver Strain Index), COPE Index y CBS (Caregiver Burden Screen)(7). No todos cumplen el mismo papel: algunos captan mejor reacción y efectos del cuidado; otros, esfuerzo/strain; otros, necesidades de apoyo o incluso puntos de corte clínicamente relevantes para riesgo. Esto refuerza la idea de que la selección depende del objetivo de la valoración (8)

6. Instrumento de adopción del rol cuidador

La Escala de Adopción del Rol en cuidadores de personas en cuidados paliativos tiene un potencial relevante porque evalúa un constructo distinto y estratégicamente importante: la transición y consolidación del rol cuidador. En comparación con la evidencia revisada sobre instrumentos de sobrecarga, su principal fortaleza es aportar una lectura más amplia sobre preparación, corresponsabilidad, apoyo, equilibrio y organización del cuidado. No obstante, su evidencia psicométrica es aún inicial: la estructura original no se confirmó, varias subdimensiones muestran consistencia interna limitada y la sensibilidad al cambio no fue demostrada. Por ello, su mejor ubicación metodológica sería como instrumento complementario y no como sustituto de las escalas de burden ya consolidadas para clasificación de riesgo.

La siguiente matriz sintetiza las características de cada instrumento:

Tabla 2. Matriz comparativa de instrumentos

Instrumento	Qué mide	Propiedades psicométricas reportadas en la evidencia	Ventajas	Limitaciones	Indicación de uso sugerida
Zarit Burden Interview (ZBI)	Sobrecarga global del cuidador; integra dimensiones subjetivas y parte de la carga objetiva.	Es el instrumento más usado. La revisión de Tu et al (2022) lo recomienda por validez, confiabilidad y factibilidad. La versión de 22 ítems tarda menos de 10 minutos. En distintos estudios mostró muy buena consistencia interna, con alfa de Cronbach reportada entre 0,71 y 0,93 según versión y población; varias versiones cortas también mostraron buen desempeño, por ejemplo 12 ítems 0,88, 4 ítems 0,78, 22 ítems en distintas validaciones alrededor de 0,859–0,93. Se describe además buena confiabilidad interevaluador y múltiples validaciones transculturales.	Muy conocido, muchas traducciones y versiones breves, relativamente rápido, útil para seguimiento longitudinal y para uso en distintos contextos clínicos. La revisión integrativa reporta niveles interpretativos de carga: 0–20 sin o poca carga; 21–40 leve-moderada; 41–60 moderada-severa; 61–88 severa. En Colombia es la escala con mayor número de estudios de validación, incluida su versión breve, y la Resolución 3280 de	Más bien unidimensional; puede mezclar carga objetiva y subjetiva; no debe usarse como único indicador del estado emocional, sino complementarse con observación clínica u otras escalas. Zarit no debería asumirse como una escala universal para "cualquier tipo de cuidador" en sentido irrestricto. ZBI aparece descrito para cuidadores primarios adultos, es decir, familiares, amigos o personas allegadas de personas mayores con demencia y otras condiciones, cuidadas en casa. Es	La Escala de Zarit puede emplearse como herramienta base para valorar sobrecarga en cuidadores informales, principalmente familiares o allegados que asumen el cuidado de personas con dependencia o enfermedad crónica en el entorno hogar. Su uso está ampliamente respaldado en cuidadores de personas mayores, especialmente en demencia, y también se ha extendido a otros contextos de cuidado; sin embargo, su interpretación debe

Instrumento	Qué mide	Propiedades psicométricas reportadas en la evidencia	Ventajas	Limitaciones	Indicación de uso sugerida
			2018 establece su aplicación para evaluar la sobrecarga de las personas que asumen el rol de cuidador(18–20) .	decir, su punto de partida es el cuidado informal en entorno hogar, no todo posible tipo de cuidador	contextualizarse según el tipo de cuidador y complementarse con otras fuentes de información clínica, familiar y social. El puntaje no reemplaza la valoración clínica integral ni la entrevista familiar, y debe interpretarse siempre dentro del contexto familiar, social y funcional del cuidador.
Burden Scale for Family Caregivers (BSFC / BSFC-s)	Estrés y carga derivados de la situación de cuidado; incluye referencia a tareas e intensidad del apoyo.	La revisión de demencia la recomienda entre los mejores instrumentos. Tiene versión larga de 28 ítems y corta de 10 ítems. En cuidadores de personas con demencia mostró alfa de Cronbach de 0,93 para la versión larga y 0,915 para la corta, con estructura unifactorial. La revisión	Muy fácil de entender, puede ser autoadministrada, 5–10 minutos, útil tanto en práctica como en investigación. La versión corta la hace muy atractiva para primer nivel.	Sigue siendo predominantemente unidimensional, por lo que discrimina peor perfiles específicos de carga. Aunque es sensible para carga global, ofrece menos detalle para decidir qué tipo de apoyo necesita el cuidador. La evidencia revisada	Muy buena opción para tamizaje rápido en entorno hogar cuando se quiera una escala simple y autoadministrable. Útil para decidir si el cuidador necesita acompañamiento básico vs. ampliado, pero menos útil para

Instrumento	Qué mide	Propiedades psicométricas reportadas en la evidencia	Ventajas	Limitaciones	Indicación de uso sugerida
		integrativa además reporta puntuación total 0–84, Likert 0–3, validada en alemán e inglés.		reporta validación en alemán e inglés; no se identificaron estudios de validación en Colombia.	perfilar el tipo de intervención.
Caregiver Burden Inventory (CBI)	Carga multidimensional del cuidador.	La revisión en demencia reporta 24 ítems, puntuación Likert, alfa global de 0,91, con alfas por factor entre 0,79 y 0,93. Se validó en varios países y lenguas. Identifica cinco dominios: emocional/psicológico, dependencia del tiempo, físico, evolutivo/desarrollo y social. La revisión integrativa la describe como validada en inglés e italiano y útil para construir un perfil individual de carga.	Es la mejor alternativa cuando interesa un perfil de riesgo más fino y no solo un puntaje global. Facilita intervenciones dirigidas porque muestra dónde está concentrada la carga.	No ofrece puntos de corte tan estandarizados para clasificación simple; suele requerir más apoyo profesional para interpretación y definición de medidas. No se identificaron estudios de validación en Colombia, por lo que en el territorio su uso debe ser complementario al ZBI.	Recomendada cuando el tamizaje inicial sale alterado o cuando el caso es complejo. Muy útil para decidir intensidad y tipo de acompañamiento: apoyo emocional, relevo, trabajo en red, educación en cuidado, intervención social, etc.
Screen for Caregiver	Carga del cuidador específica para demencia, con lectura de dominios.	La revisión en demencia la recomienda entre los mejores instrumentos.	Más específico y sensible para detectar carga como	La evidencia disponible está mucho más centrada	Muy útil cuando la familia cuida a una persona con

Instrumento	Qué mide	Propiedades psicométricas reportadas en la evidencia	Ventajas	Limitaciones	Indicación de uso sugerida
Burden (SCB)		Tiene versión de 25 ítems y una corta de 7 ítems. Presenta seis dominios en tres categorías; la confiabilidad reportada es >0,65 en la versión larga y 0,86 en la corta. Mostró validez de criterio por correlación con ansiedad/salud mental y validez de constructo al diferenciar entre cuidadores y controles.	fenómeno diferenciado; la versión corta es atractiva para uso ágil.	en demencia; por eso su extrapolación a otros contextos familiares es menos directa. No se identificaron estudios de validación en Colombia.	demencia o deterioro cognitivo y se requiere una escala breve pero con mejor diferenciación de dominios que ZBI.
Caregiver Strain Index (CSI)	Esfuerzo/strain del cuidador más que carga multidimensional completa.	La revisión en demencia reporta 13 ítems sí/no, con alfa de Cronbach alrededor de 0,86 y correlación criterio con salud emocional del cuidador. Sin embargo, la misma revisión señala que requiere más estudios psicométricos en demencia.	Muy corto y simple.	Menos completo para necesidades complejas; parece más útil como aproximación al esfuerzo que como lectura amplia de la carga. Cuenta con traducción al español, pero no se identificaron estudios de validación en Colombia.	Opción secundaria cuando se necesite una medición muy breve del esfuerzo del cuidador, no ideal como herramienta principal para clasificar intensidad de acompañamiento en familias complejas.

Instrumento	Qué mide	Propiedades psicométricas reportadas en la evidencia	Ventajas	Limitaciones	Indicación de uso sugerida
Escala de Adopción del Rol del Cuidador Familiar del Paciente en Cuidados Paliativos (ROL-Pal)	Adopción del rol cuidador en contexto paliativo. Evalúa cómo el cuidador asume, organiza e integra el rol en su vida cotidiana, incluyendo competencia/preparación, apoyo/corresponsabilidad, relación cuidador-paciente, autocuidado emocional, logística/recursos, conocimientos y equilibrio del rol. No mide sobrecarga como constructo principal.	Estudio con 434 cuidadores familiares en Medellín. Validez de contenido adecuada: IVC global 0,92 en claridad y 0,88 en relevancia. El AFC no confirmó la estructura original de 3 factores; el AFE identificó 7 dimensiones que explicaron 54,59 – 54,70 % de la varianza. Consistencia interna global aceptable: α = 0,711–0,712; omega = 0,79. Estabilidad test-retest global adecuada: CCI = 0,815. Validez concurrente moderada con calidad de vida del cuidador: Rho = 0,512; p < 0,001. Validez de grupos conocidos: discriminó entre cuidadores únicos vs. con apoyo (p < 0,001) y entre <3 meses vs. ≥4 meses en el rol (p =	Aporta una dimensión poco cubierta por Zarit y otras escalas clásicas: la transición y consolidación del rol cuidador. Tiene alto valor para entender si el cuidador cuenta con preparación, apoyo, corresponsabilidad y equilibrio vital. Puede orientar mejor el tipo de acompañamiento requerido que un simple puntaje global de burden. Además, es un instrumento desarrollado y adaptado en contexto colombiano y en español.	La evidencia psicométrica es inicial. La estructura original no se confirmó y varias subdimensiones muestran consistencia interna baja, especialmente las dimensiones 5 y 6; la dimensión 5 también tuvo baja estabilidad (CCI 0,267). La muestra fue de cuidadores de pacientes hospitalizados en paliativos, lo que limita extrapolación al entorno hogar comunitario. No debe interpretarse como sustituto de una escala de sobrecarga.	Instrumento complementario, no sustituto de Zarit. Recomendable cuando se quiera valorar adopción del rol, especialmente en cuidados paliativos o trayectorias avanzadas de enfermedad. Útil como segunda capa de valoración tras identificar al cuidador, para orientar intervenciones en educación, corresponsabilidad, red de apoyo, autocuidado y organización del cuidado. No lo usaría como único criterio para clasificar riesgo o intensidad del acompañamiento.

Instrumento	Qué mide	Propiedades psicométricas reportadas en la evidencia	Ventajas	Limitaciones	Indicación de uso sugerida
		0,046). Sensibilidad al cambio no demostrada tras intervención educativa breve.			

Fuente: Elaboración propia.

De manera complementaria es importante mencionar que la evidencia sobre determinantes es bastante clara (2,7,9), los factores más consistentemente asociados con mayor carga del cuidador son:

- Mayor dependencia funcional de la persona cuidada.
- Problemas conductuales del receptor del cuidado.
- Más tiempo y duración del cuidado.
- Síntomas depresivos/ansiosos o peor salud del cuidador.
- Dificultades económicas.
- Menor disponibilidad de apoyo social, servicios de relevo o recursos psicológicos como resiliencia y afrontamiento.
- Factores de la dinámica familiar, como el conflicto de rol, la ausencia de ayuda y la concentración del cuidado en una sola persona, descritos por Lindt e Isac.

Además, la carga subjetiva no es trivial, de acuerdo con el metaanálisis de del-Pino-Casado et al., se encontró una asociación grande entre carga subjetiva y síntomas de ansiedad en cuidadores informales, lo que apoya usar la carga no solo como indicador social, sino también como señal de riesgo clínico y psicosocial (21).

De acuerdo con los hallazgos de la revisión el abordaje debería centrarse en un primer momento de identificación del rol cuidador, donde no se usa una escala de sobrecarga como único mecanismo de "detección del cuidador". Conviene en su lugar, un tamizaje breve y proactivo en la visita familiar, por ejemplo, con preguntas guía breves o una lista de verificación corta:

- ¿Quién realiza la mayor parte del cuidado diario?
- ¿Cuántas horas al día/semana dedica al cuidado?
- ¿Hace cuánto asumió ese rol?
- ¿Tiene relevo?
- ¿Ha dejado trabajo/estudio/actividades por cuidar?
- ¿Percibe cansancio físico o emocional?
- ¿Quién toma las decisiones sobre el cuidado?
- ¿Asumió el rol de cuidado de manera voluntaria o por obligación?
- ¿Cuál considera que es actualmente su principal necesidad?

En un segundo momento, de acuerdo con el tamizaje, la clasificación del riesgo del cuidador por medio de una escala validada:

- ZBI si se necesita una opción estándar, conocida, breve y ya instalada en el territorio.
- BSFC si se prioriza facilidad de uso y seguimiento periódico.
- CBI o SCB si se quiere una lectura más multidimensional y útil para orientar intervención específica.

En un tercer momento, el resultado de la escala se integra con variables contextuales y de red para clasificar el riesgo y ajustar la intensidad del acompañamiento: dependencia funcional y problemas conductuales de la persona cuidada, duración e intensidad del cuidado, salud física y mental del cuidador, dificultades económicas, disponibilidad de relevo y apoyo social, y dinámica familiar. Para la lectura de la red y de la dinámica familiar pueden utilizarse el familiograma, el ecomapa y el APGAR familiar, herramientas de uso cotidiano en el marco del PICF. Los criterios de esta clasificación se desarrollan en la Pregunta 3.

En síntesis, en el entorno hogar, la identificación de la adopción del rol cuidador no debe descansar únicamente en escalas de sobrecarga. La evidencia favorece una estrategia proactiva y escalonada: primero, preguntas breves o checklist para reconocer tempranamente quién cuida, desde cuándo, con qué intensidad y con qué apoyos; segundo, aplicación de instrumentos validados de carga; y tercero, integración de variables contextuales y de red para clasificar el riesgo y ajustar la intensidad del acompañamiento. Entre los instrumentos con mejor respaldo se encuentran el Zarit Burden Interview (ZBI), por su amplio uso, brevedad y múltiples validaciones; la Burden Scale for Family Caregivers (BSFC), por su facilidad de uso y potencial para seguimiento; el Screen for Caregiver Burden (SCB) y el Caregiver Burden Inventory (CBI), por su carácter más multidimensional. Desde una perspectiva de enfoque de salud familiar, la clasificación del riesgo debe considerar no solo el puntaje de la escala, sino también la dependencia funcional y problemas conductuales de la persona cuidada, la duración/intensidad del cuidado, la salud mental y física del cuidador, las dificultades económicas y la disponibilidad de apoyo social y relevo. En el contexto del PICF, esto respalda mantener Zarit como herramienta base —por ser la escala con más estudios de validación en Colombia y la establecida en la Resolución 3280 de 2018—, y complementarla con un mecanismo breve de identificación del rol cuidador y con los instrumentos de valoración familiar (familiograma, ecomapa y APGAR familiar), para decidir mejor la intensidad del acompañamiento. Cuando se requiera perfilar las dimensiones de la carga, el CBI puede utilizarse como complemento, teniendo en cuenta que no se identificaron estudios de su validación en Colombia. Las acciones concretas para el profesional durante la visita domiciliaria se presentan en la sección de pautas de la Pregunta 1.

Tabla 3. Estrategia escalonada para la identificación del cuidador y la valoración de la sobrecarga

Momento	Qué hacer en la visita	Herramientas
1. Identificación proactiva del rol cuidador	Preguntar quién cuida, qué tareas asume, cuántas horas dedica, desde cuándo, si tiene	Preguntas guía o lista de verificación para cuidadores.

Momento	Qué hacer en la visita	Herramientas
	relevo, quién decide y cuál es su principal necesidad. Registrar el rol aunque la persona no se reconozca como cuidadora.	
2. Tamizaje de la sobrecarga	Aplicar la escala cuando el cuidado sea frecuente o prolongado, exista dependencia o problemas conductuales, no haya relevo o el cuidador refiera cansancio o afectación de su salud.	ZBI en versión validada en Colombia; CBI como complemento si se requiere perfilar dimensiones.
3. Clasificación del riesgo y decisión de la intensidad del acompañamiento	Integrar el puntaje con la situación de la persona cuidada, la salud del cuidador, la red de apoyo, la economía familiar y la seguridad. Clasificar en riesgo bajo, moderado, alto o crítico.	Familiograma, ecomapa y APGAR familiar; criterios de la Pregunta 3.

Fuente: Elaboración propia.

8.2 Pregunta 2

En cuidadores familiares o informales de personas con necesidades distintas de cuidado, ¿qué intervenciones estructuradas dirigidas al cuidador han demostrado efectividad para reducir la sobrecarga, mejorar la salud del cuidador y favorecer la sostenibilidad del cuidado en el hogar?

Síntesis de la evidencia:

Para responder a la pregunta sobre las intervenciones estructuradas dirigidas al cuidador que reducen la sobrecarga, mejoran su salud y favorecen la sostenibilidad del cuidado en casa, se identificaron 17 revisiones sistemáticas de la literatura (RSL) que incluyeron estudios para cuidadores informales en el entorno hogar en distintas condiciones de salud y grados de dependencia. En este sentido la evidencia recabada es heterogénea y en algunos casos indirecta. En términos generales, la base de evidencia incluida está dominada por estudios en demencia, discapacidad y dependencia en personas mayores, con una parte menor en cáncer, cuidados paliativos, tumor cerebral/medular, deterioro cognitivo leve y disnea crónica. Por tanto, la extrapolación a personas con necesidades distintas de cuidado es razonable, pero debe hacerse con

cautela porque el volumen y la calidad de la evidencia son muy desiguales entre condiciones. En demencia se concentran los metaanálisis y revisiones más robustos; en cáncer y paliativos predominan revisiones narrativas o sistemáticas con heterogeneidad alta; y en neurooncología y deterioro cognitivo leve la evidencia es todavía pequeña e incierta.

1) Intervenciones psicosociales

El cuerpo de evidencia más consistente favorece las intervenciones psicosociales estructuradas, especialmente cuando incluyen psicoeducación, entrenamiento en afrontamiento, resolución de problemas, apoyo emocional o terapia cognitivo-conductual. El metanálisis en red más reciente en cuidadores de personas mayores con discapacidad incluyó 31 ensayos y 4687 participantes y mostró que las intervenciones basadas en mindfulness (MBI) fueron las que ocuparon el primer lugar en reducción de carga del cuidador (SMD = −6.67; IC95%: −12.94 a −0.41; SUCRA 79.2%). En el subgrupo de cuidadores de personas con deterioro cognitivo, las MBI también fueron las mejores (SMD = −17.06; IC95%: −25.02 a −9.10; SUCRA 98.7%), mientras que en intervenciones realizadas en el hogar la terapia cognitivo-conductual (TCC) fue la más efectiva (SMD = −5.57; IC95%: −8.59 a −2.90; SUCRA 95.7%)(22). Aunque estas estimaciones deben leerse con prudencia por la baja confianza de varias comparaciones, el patrón es claro: mindfulness y TCC son las estrategias con mejor señal de efectividad (23–27).

En la revisión sistemática de intervenciones psicosociales para cuidadores de personas con demencia, que incluyó 43 estudios, la carga se redujo después de la intervención en 19 estudios, y en 10 estudios adicionales se redujo en al menos una de varias medidas utilizadas. Los enfoques con mayor proporción de éxito fueron psicoeducación y programas multicomponente, ambos con resultados favorables en alrededor de la mitad de los estudios. Esto no significa que siempre funcionen, sino que son las modalidades con mayor recurrencia de resultados positivos en la literatura disponible (28,29).

2) Terapia cognitivo-conductual y resolución de problemas.

Las revisiones sobre TCC muestran un patrón bastante estable: mejora sobre todo depresión, ansiedad, estrés y bienestar emocional, y de forma menos uniforme la carga global. En la revisión de intervenciones cognitivo-conductuales para población cuidadora, que analizó 18 estudios, se reportaron mejoras significativas en depresión, ansiedad, bienestar emocional, estrés y carga, y las técnicas más repetidas fueron resolución de problemas, estrategias de afrontamiento y ejercicios de respiración. Además, las modalidades virtuales fueron frecuentes, lo que

sugiere una buena adaptabilidad de este enfoque a formatos híbridos o remotos(30).

De manera más precisa, el metaanálisis de Vázquez sobre intervenciones psicológicas breves en cuidadores mostró que la mayoría logró reducir síntomas depresivos, con un tamaño del efecto combinado moderado (d = −0.61). Los mejores resultados se observaron cuando la intervención se basó en el modelo integrador multifactorial de la depresión o en resolución de problemas, se dirigió a cuidadores con síntomas depresivos o riesgo de depresión, tuvo la depresión como objetivo principal y se implementó con bajo riesgo de sesgo(31). Esto es particularmente relevante para el abordaje del cuidador en la familia, porque sugiere que las intervenciones breves, focalizadas y con indicación clara pueden ser más efectivas que apoyos genéricos.

En revisiones oncológicas, la misma dirección aparece. Jadalla clasifica como "recomendadas para la práctica" las intervenciones psicoeducativas, de apoyo y cognitivo-conductuales, y como "probablemente efectivas" el entrenamiento en habilidades, las intervenciones de pareja, el apoyo a la toma de decisiones, el mindfulness, los programas multicomponente y algunos modelos de cuidados paliativos(32). En cáncer, el beneficio más repetido no es un desenlace único, sino un paquete de resultados: mejor afrontamiento, mayor autoeficacia, menor distrés y pequeñas mejoras en carga.

3) Mindfulness y relajación

Se identificaron 2 RSL que abordaron específicamente el tema de mindfulness y relajación en cuidadores informales en el entorno hogar, las cuales reportan un beneficio consistente en depresión y estrés, pero con menor claridad de efecto en sobrecarga de cuidado. El mejor ejemplo cuantitativo de este patrón es el metaanálisis de Liu en cuidadores familiares de personas con demencia. Con 7 ensayos clínicos aleatorizados (ECA), el mindfulness redujo significativamente la depresión (SMD = −0.58; IC95%: −0.79 a −0.37), el estrés percibido (SMD = −0.33; IC95%: −0.57 a −0.10) y mejoró la calidad de vida mental (SMD = 0.38; IC95%: 0.14 a 0.63), pero no mostró ventaja significativa sobre los controles en carga del cuidador (SMD = −0.08; IC95%: −0.42 a 0.26) ni en ansiedad (SMD = −0.35; IC95%: −0.71 a 0.01). Por tanto, el mindfulness parece ser una intervención especialmente útil cuando el objetivo principal es reducir sufrimiento emocional, más que modificar por sí sola toda la experiencia de carga.(27)

La revisión de Jaffray en cuidadores paliativos va en el mismo sentido que la evidencia anterior, dónde las intervenciones basadas en mindfulness fueron factibles y aceptables, y los resultados fueron más consistentes

para reducir depresión y carga e incrementar calidad de vida, aunque con efectos menos robustos que en otras poblaciones y con predominio de estudios en demencia(24). Es decir, hay una señal de beneficio, pero aún no una base suficientemente fuerte para asumir efectos grandes o universales en paliativos.

4) Intervenciones remotas, telefónicas y por internet

Frente a las intervenciones basadas en acompañamiento o seguimiento remoto, la evidencia muestra que pueden ser útiles como complemento, pero no siempre resultan ser superiores a la atención habitual. La revisión de Egan encontró 8 ECA de programas en línea para cuidadores de personas con demencia. En conjunto, halló alguna evidencia de mejoría en salud mental, pero la heterogeneidad metodológica fue tan alta que no se pudieron agrupar robustamente los resultados. Además, no hubo estudios que reportaran calidad del cuidado como resultado directo. Esto sugiere que la virtualidad tiene potencial, pero la literatura temprana era aún fragmentada(33).

La revisión Cochrane de González-Fraile ofrece una estimación más sólida(23). En cuidadores de personas con demencia, cuando las intervenciones remotas con entrenamiento y/o apoyo se compararon con atención usual, lista de espera o atención inespecífica, probablemente tuvieron poco o ningún efecto en carga (SMD = −0.06; IC95%: −0.35 a 0.23), síntomas depresivos (SMD = −0.05; IC95%: −0.22 a 0.12) y calidad de vida relacionada con la salud (SMD = 0.10; IC95%: −0.13 a 0.32). En cambio, cuando se compararon con información sola, sí mostraron una ligera reducción de carga (SMD = −0.24; IC95%: −0.51 a 0.04) y una ligera mejoría en síntomas depresivos (SMD = −0.25; IC95%: −0.43 a −0.06), aunque a costa de más abandonos (RR = 1.51; IC95%: 1.04 a 2.20)(23). Además, la evidencia sobre institucionalización fue muy incierta (RR = 2.67; IC95%: 0.12 a 60.93). En términos prácticos: lo remoto sirve mejor como intensificación de la información que como sustituto claro de la atención usual(23).

5) Ejercicio físico y relajación muscular

La revisión de Cardoso incluyó 11 ECA y 2 estudios experimentales sobre ejercicio o relajación muscular en cuidadores familiares. Aunque los programas fueron heterogéneos, la mayoría mostró efectos positivos en el bienestar físico y psicológico, con reducción de burden y estrés. El artículo destaca, además, que los formatos flexibles y domiciliarios y las combinaciones de ejercicio con técnicas de relajación parecen especialmente prometedores, lo que es muy pertinente para el entorno hogar(34).

Esta línea se refuerza en la revisión de intervenciones enfermeras, es decir, acciones de cuidado planificadas y realizadas por profesionales de enfermería, como visitas domiciliarias, educación y psicoeducación, apoyo con tecnologías y seguimiento, realizada por Camarena-Tinoco et al., la cual muestra que la actividad física mejoró no solo la salud física, sino también ansiedad, depresión y calidad de vida, aunque el conjunto de la revisión concluye que las intervenciones más consistentemente efectivas siguen siendo visitas domiciliarias y programas psicoeducativos, más que la actividad física aislada(35).

6) Intervenciones de enfermería, visitas domiciliarias y programas psicoeducativos

Las revisiones de Brito(36) y Camarena(35) son especialmente útiles para la aplicabilidad. Ambas concluyen que las intervenciones enfermeras reducen la sobrecarga y mejoran variables asociadas al desempeño del rol. Brito resume que los principales factores de riesgo de sobrecarga son la falta de conocimientos, la ausencia de tiempo personal, la ausencia de redes de apoyo, la prolongación de las necesidades del paciente y la falta de habilidades emocionales; como factores de protección, identifica conocimiento, habilidades sociales/emocionales y apoyo percibido. Además, concluye que fortalecer resolución de problemas, comunicación asertiva e información práctica sobre las necesidades de cuidado ayuda a prevenir sobrecarga(36).

Camarena et al, por su parte, revisó 18 ensayos clínicos y encontró efectividad en la reducción de estrés, ansiedad, depresión y necesidades no satisfechas. Señala como intervenciones con mejor desempeño las visitas domiciliarias y los programas psicoeducativos, tanto grupales como individuales. En algunos estudios específicos incluidos en la revisión, el apoyo domiciliario redujo significativamente la sobrecarga, y los modelos de caso/seguimiento mejoraron vitalidad, rol social y bienestar general(35). También se observaron mejorías de corto plazo en estrés del cuidador y preparación para cuidar, aunque no siempre en bienestar psicológico global. Esto sugiere que, para una pauta basada en evidencia, las intervenciones enfermeras de proximidad son una de las estrategias más transferibles al PICF.

7) Resultados por condición clínica de la persona que se cuida.

En disnea crónica (EPOC, falla cardiaca, asma y otras condiciones con disnea persistente), el metaanálisis de Liu aporta una de las mejores aproximaciones al concepto de "sostenibilidad del cuidado". En 25 ECA (2425 participantes), las intervenciones redujeron significativamente la carga global (SMD = −0.65; IC95%: −0.96 a −0.34), el estrés (SMD = −0.59), la depresión (SMD = −0.45), y mejoraron la función familiar

(SMD = 0.53) y la confianza para manejar el estrés (SMD = 0.30). No encontraron cambios significativos en ansiedad (SMD = −0.28), apoyo social (SMD = 0.55) ni calidad de vida (SMD = 0.16). El mayor efecto se observó en la carga social (SMD = −1.07), lo que sugiere que muchas intervenciones ayudan más a reorganizar el cuidado y la interacción familiar/social que a transformar rápidamente toda la calidad de vida del cuidador(27).

En tumores cerebrales y medulares, la revisión Cochrane de Boele encontró que hubo alguna evidencia de mejoría en distrés psicológico, dominio clínico y calidad de vida, pero sin efecto claro en la sobrecarga, relación cuidador-paciente ni funcionamiento físico del cuidador(25). Un estudio mostró mejoría en dominio clínico ($\Delta R^2 = 0.055$; $p = 0.021$) y otro en la subescala de vitalidad del SF-36 a 8 semanas y 6 meses (MD 14.03 y 15.45; $p = 0.026$), pero el conjunto fue de certeza baja o muy baja. Esto sugiere beneficio posible, aunque todavía incierto(25).

En deterioro cognitivo leve, Domingues identificó solo cuatro estudios, con resultados prometedores, pero aún inconclusos. El entrenamiento en calendario y toma de notas disminuyó síntomas depresivos del cuidador y frenó el empeoramiento de la carga subjetiva a 6 meses; además, una intervención con actividades significativas más resolución de problemas redujo depresión, y una intervención educativa con llamadas sociales redujo la sobrecarga a 3 meses. Sin embargo, el número de estudios es pequeño y con sesgos relevantes(26).

En cáncer y paliativos, la evidencia sugiere que las intervenciones psicoeducativas, de apoyo y TCC mejoran distrés, afrontamiento, autoeficacia y algunos dominios de calidad de vida, pero el efecto sobre la sobrecarga es variable(32). En la síntesis de Jadalla, por ejemplo, un estudio de intervención psicoeducativa telefónica mostró descensos mayores de depresión, ansiedad y sobrecarga ($p < 0.001$), y la atención paliativa temprana mejoró satisfacción del cuidador y en algunos estudios el distrés psicológico, aunque no consistentemente la calidad de vida o la carga(32).

En conjunto, la evidencia permite responder que sí existen intervenciones estructuradas dirigidas al cuidador que mejoran su salud, especialmente en los dominios de sobrecarga, depresión, estrés, dominio clínico/autoeficacia, preparación para el rol y funcionamiento familiar. Las intervenciones con mejor respaldo son:

- Psicoeducación estructurada.
- Terapia cognitivo-conductual o resolución de problemas.
- Mindfulness o relajación.

- Programas multicomponente que combinen educación, apoyo emocional y habilidades prácticas.
- En el entorno hogar, visitas domiciliarias, seguimiento telefónico o modelos híbridos como complemento.

En cambio, la evidencia es menos consistente para mejorar ansiedad y calidad de vida global, y es muy limitada o incierta para desenlaces directos de sostenibilidad del cuidado en casa, como institucionalización, uso de recursos o calidad del cuidado. Donde sí hay señal de sostenibilidad es en aspectos como: menor carga, menos depresión/estrés, más confianza para enfrentar el cuidado, mayor dominio clínico, mejor preparación y mejor función familiar. En otras palabras, las intervenciones parecen sostener el cuidado en casa indirectamente, al proteger mejor al cuidador, más que por demostrar directamente que reducen institucionalización o cambian de forma robusta la calidad de vida global.

8.3 Pregunta 3

En cuidadores familiares o informales de personas con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿cuáles son los signos de alarma y los criterios de riesgo clínico, psicosocial y de seguridad que permiten identificar el deterioro de la salud física o mental, la violencia y el colapso del rol cuidador, y qué respuestas intersectoriales escalonadas deben activarse, según el nivel de riesgo, para proteger al cuidador y sostener el cuidado en casa?

La pregunta se ha dividido en dos componentes:

A. Identificación y estratificación del riesgo

Subpregunta: En cuidadores familiares o informales de personas de la familia con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿qué signos de alarma y criterios clínicos, psicosociales y de seguridad permiten identificar y estratificar riesgo de deterioro de la salud mental o física, violencia y colapso del rol cuidador?

Componente B. Respuesta y activación intersectorial

Subpregunta: En cuidadores familiares o informales con signos de alarma o alto riesgo en el entorno hogar, ¿qué respuestas y mecanismos de articulación intersectorial deben activarse, según el nivel de riesgo, para proteger al cuidador y sostener el cuidado en casa?"

Componente A. identificación del riesgo

Se revisaron 11 RSL. La evidencia revisada muestra que el deterioro del cuidador no depende de un solo factor, sino de un proceso acumulativo de sobrecarga. La revisión de Li, estructurada con el modelo de proceso

de estrés, es la más clara en este punto, en ella se describe que el "burden" del cuidador resulta de la interacción entre estresores primarios, es decir aquellas dificultades y eventos directamente relacionados con la enfermedad o dependencia de la persona cuidada y con la tarea de proveer asistencia diaria, en particular las limitaciones funcionales en ADL (Actividades básicas) y las IADL (Actividades Instrumentales), problemas conductuales y deterioro cognitivo de la persona cuidada, y estresores secundarios, como depresión, ansiedad, tiempo de cuidado, dificultades económicas; a su vez, el apoyo social, el uso de servicios y los recursos psicológicos como la resiliencia y el afrontamiento actúan como factores protectores. La revisión concluye que la dependencia funcional y los problemas conductuales son los correlatos más consistentes del aumento del "agotamiento" del cuidador y que los síntomas depresivos, la dedicación prolongada al cuidado y los problemas financieros son marcadores secundarios fuertes de riesgo(37).

1. Signos de alarma ligados a la persona cuidada

El primer grupo de criterios de alarma proviene de la complejidad clínica y funcional de la persona a quien se cuida. De forma consistente, el riesgo del cuidador aumenta cuando la persona cuidada presenta:

- Dependencia funcional importante en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.
- Problemas conductuales o neuropsiquiátricos.
- Deterioro cognitivo.
- Comorbilidades/multimorbilidad.
- Alteraciones de memoria y sueño.

La revisión de Lindt (38) resume que los predictores más importantes de sobrecarga son la duración del cuidado y el nivel de dependencia de la persona a quien se cuida, tanto física como mental, incluyendo disminución de la capacidad cognitiva y problemas conductuales; además, ciertos diagnósticos y el conflicto de rol aumentan la sobrecarga, mientras que el apoyo social la reduce(38).

Cuando el cuidado ocurre en contextos de demencia, la evidencia es todavía más específica. La revisión de Feast muestra que los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia (BPSD) son predictores relevantes del "cuidador quemado", depresión del cuidador e institucionalización(39). Entre los síntomas que más distrés generan al cuidador destacan las conductas depresivas, seguidas por agitación/agresión y apatía; y, en el análisis correlacional, irritabilidad, conducta motora aberrante y delirios fueron los síntomas más

fuertemente relacionados con distrés del cuidador. Esto permite considerar estos síntomas como señales de alarma prioritarias en la valoración del entorno hogar.

En la revisión de Isac en países asiáticos, también se reporta que la dependencia funcional, las comorbilidades, los déficits de memoria y los trastornos del sueño del adulto mayor incrementan la carga del cuidador(40). En otras palabras, cuando el cuidado exige supervisión constante, apoyo físico frecuente o manejo de síntomas conductuales complejos, el riesgo del cuidador debe asumirse como más alto (40).

2. Signos de alarma clínicos y psicosociales del cuidador

El segundo grupo corresponde a manifestaciones del propio cuidador. La evidencia converge en que deben considerarse signos de alarma:

- Síntomas depresivos.
- Ansiedad.
- Estrés/distrés persistente.
- Mala salud autopercibida o empeoramiento del estado de salud.
- Agotamiento, sobrecarga, burnout o exhaustación.
- Aislamiento social.
- Conflicto y sobrecarga de rol.
- Dificultades económicas/estrés financiero.

Li identifica como estresores secundarios con mayor impacto: la depresión, la ansiedad, el tiempo de cuidado y las dificultades financieras (37). Además, muestra que un mejor estado de salud del cuidador se asocia consistentemente con menor sobrecarga. Esto tiene una implicación práctica clara, cuando el cuidador ya presenta sintomatología emocional o deterioro físico, no se trata solo de una consecuencia del cuidado, sino de un criterio útil para clasificar mayor riesgo(37).

La revisión de Loo para Singapur refuerza este hallazgo, la sobrecarga se asocia con peor salud autopercibida, síntomas depresivos y reducción de calidad de vida. En uno de los estudios incluidos de esta revisión, los cuidadores tuvieron mayores probabilidades de peor salud autopercibida, síntomas depresivos clínicamente significativos y más consultas ambulatorias; en otro, la distimia y ciertas estrategias negativas de afrontamiento incrementaron la probabilidad de sobrecarga(12).

Las revisiones de Wangler y Marx, centradas en atención primaria, son especialmente útiles para el componente A porque cambian la pregunta de: qué tan cargado está a qué debe hacer sospechar riesgo temprano (17). Ambas coinciden en que la falta de identificación precoz deja a muchos cuidadores sin apoyo hasta que aparecen agotamiento, ansiedad o síntomas depresivos, mayor mortalidad, estilo de cuidado deteriorado y

hasta conducta abusiva. Esta revisión subraya que muy pocos cuidadores son identificados tempranamente porque no suelen reconocerse a sí mismos como tales y no piden ayuda; esto aumenta el riesgo de morbilidad física y psicológica secundaria(17).

3. Criterios ligados a intensidad y sostenibilidad del rol

Un tercer grupo de criterios de riesgo no describe síntomas, sino condiciones del cuidado que anticipan deterioro. Los más consistentes son:

- Largos periodos de cuidado o cuidado prolongado.
- Alta intensidad/dedicación horaria.
- Coexistencia de múltiples tareas complejas.
- Ausencia de relevo o ayuda.
- Cuidado en soledad.
- Ser cónyuge cuidador en ciertos contextos.
- Dificultad percibida para asistir en las tareas.

Lindt resume que la duración del cuidado es uno de los predictores más importantes de sobrecarga y agotamiento (38). Isac añade que la sobrecarga se intensifica con una mayor duración del cuidado, la falta de ayuda y, en la evidencia revisada, cuando el cuidador atiende a un cónyuge (40). Esto sugiere que en el entorno hogar no basta con preguntar "¿cómo se siente?"; también hay que preguntar cuánto cuida, qué tareas asume, si duerme, si tiene relevo, si comparte decisiones y si se siente capaz de seguir sosteniendo el cuidado. Esa dimensión operativa es parte del riesgo.

4. Criterios de seguridad y potencial riesgo de violencia

Los textos seleccionados no ofrecen umbrales validados ni escalas específicas para estratificar violencia del cuidador o hacia el cuidador. La mayor parte de la literatura opera como sobrecarga, distrés o salud mental como variables proxy. Por tanto, en este componente la inferencia debe hacerse con cautela.

Aun así, sí emerge un patrón razonable para la identificación del riesgo de seguridad: el potencial de desborde aumenta cuando coinciden síntomas conductuales altamente perturbadores de la persona cuidada como por ejemplo: agitación/agresión, irritabilidad, delirios, conducta motora aberrante, trastornos del sueño o deambulación problemática, lo anterior con un cuidador que ya presenta agotamiento, mal afrontamiento, aislamiento, distrés o burnout, es un riesgo muy alto para desatar agresiones psicológicas y físicas. Feast muestra que estos síntomas son los que más distrés provocan(39); Marx y Wangler señalan que la sobrecarga persistente se vincula a consecuencias severas, entre

ellas comportamientos de abuso mencionado como riesgo en atención primaria (17).

Entonces, aunque no haya una regla validada específica para violencia, es posible considerar como alarma de seguridad la combinación de:

- Cuidador exhausto o con salud mental deteriorada.
- Ausencia de apoyo o relevo.
- Pobre capacidad de afrontamiento.
- Receptor de cuidado con síntomas conductuales desorganizados o agresivos.

Lo anterior, justificaría activar valoración clínica y psicosocial más intensiva, es decir, con mayor frecuencia de contactos, mayor profundidad de la valoración y participación de profesionales de salud mental o trabajo social.

5. *Factores protectores útiles para la estratificación del riesgo*

La estratificación del riesgo no debe basarse solo en signos de alarma; también debe incorporar factores protectores. La evidencia identifica como más relevantes los siguientes:

- ✓ Apoyo social y familiar percibido.
- ✓ Utilización de servicios y acceso a relevo/respiro.
- ✓ Resiliencia.
- ✓ Estrategias de afrontamiento adaptativas.
- ✓ Autoeficacia, dominio del cuidador, competencia y preparación para cuidar.

Isac encontró que aquellos cuidadores que mostraban niveles relativamente buenos de apoyo social, resiliencia y competencia, contenían y manejaban mejor las cargas de cuidado y plantea que estos recursos son bases para el empoderamiento del cuidador(40). Li identifica de forma consistente que el apoyo social, uso de servicios y recursos psicológicos son moduladores protectores para el cuidador(37). Amer también sugiere que evaluar la dificultad de las tareas y el uso de servicios de apoyo puede ayudar a descubrir necesidades ocultas de conocimiento o soporte del cuidador (41).

Escala operativa basada en la evidencia:

Riesgo bajo:

Cuidador sin síntomas clínicos relevantes, con sobrecarga leve o ausente, buen apoyo social, relevo disponible, salud propia estable y demandas del receptor de cuidado manejables. Los problemas cognitivos o conductuales son leves y no alteran de forma importante el funcionamiento del hogar.

Esto es coherente con los factores protectores descritos en Li e Isac. En este nivel la actuación es preventiva: educación básica sobre el rol, el autocuidado y los signos de sobrecarga, promoción de la distribución de tareas y de la identificación de relevo, y reevaluación periódica.

Riesgo moderado:

Aparecen uno o varios estresores importantes, pero sin colapso manifiesto, dentro de los cuales se puede identificar: dependencia funcional creciente, comorbilidad compleja, alteraciones de sueño o memoria del receptor, sobrecarga leve-moderada persistente, malestar emocional subclínico, reducción del autocuidado, tensiones económicas o apoyo insuficiente. Este nivel requiere seguimiento y acciones preventivas porque estos factores se acumulan y anticipan mayor sobrecarga.

Riesgo alto:

Se combinan varios predictores como: síntomas depresivos o ansiosos del cuidador, mala salud autopercibida, agotamiento/exhaustación, cuidado de larga duración y alta intensidad, ausencia de ayuda, problemas financieros, y persona a quien se cuida con deterioro funcional marcado o con expresiones de demencia muy marcadas y de alto impacto en la cotidianidad. En este nivel se requiere una valoración integral y un plan individualizado de respuesta, con activación de salud mental cuando corresponda, intervención de enfermería y trabajo social, apoyo comunitario y respiro, coordinados por un profesional o gestor del caso.

Riesgo crítico o de seguridad:

Cuando se evalúe al cuidador y presente signos de desborde severo, que además coincide con problemas conductuales graves de la persona a la que se cuida, ausencia de relevo o deterioro rápido del estado mental/físico del cuidador. En esta zona ya no basta con seguimiento; se justifica activación inmediata de apoyo clínico y psicosocial intensivo.

En términos generales, la evidencia permite afirmar que los signos de alarma y criterios de estratificación del riesgo del cuidador en el entorno hogar deben organizarse en cuatro grandes ejes:

1. Complejidad de la situación de la persona(s) a quien se cuida: dependencia funcional, multimorbilidad, deterioro cognitivo, problemas conductuales, alteraciones de memoria y sueño.

2. Deterioro de la persona que cuidado: depresión, ansiedad, distrés, mala salud autopercibida, agotamiento o sensación de estar “exhausto”, aislamiento y sobrecarga creciente.

3. Sobrecarga estructural del rol: larga duración e intensidad del cuidado, ausencia de relevo, dificultad percibida para las tareas, tensión económica y conflicto de rol.
4. Riesgo de seguridad: combinación de cuidador exhausto o con mal afrontamiento y síntomas conductuales graves del receptor, especialmente agitación/agresión, irritabilidad o delirios. La evidencia directa sobre violencia es limitada, pero este patrón debe tratarse como alarma de seguridad.

La mejor lectura de conjunto es que el riesgo no debe clasificarse solo por una puntuación de sobrecarga, sino por la co-ocurrencia de estresores primarios, secundarios y protectores. Esa es la lógica más consistente con la evidencia revisada. Las recomendaciones operativas para la visita domiciliaria según el nivel de riesgo se presentan en la sección de pautas de la Pregunta 3 (ver tabla resumen al final del Componente B).

Componente b. Respuesta y activación intersectorial

A partir 11 RSL de los textos seleccionados la evidencia permite establecer que, la primera respuesta que debe activarse, incluso antes de una intervención intensiva, es la identificación sistemática y proactiva del cuidador y de sus necesidades. Riffin muestra que una checklist pragmática para atención primaria puede funcionar como herramienta para identificar necesidades y riesgos, y para abrir una conversación estructurada con el cuidador(14). La lógica de esta herramienta es muy relevante para el componente B porque sus ítems fueron diseñados como dianas modificables que pueden resolverse durante el momento de atención y se fundamentan en aspectos como la comprensión de la condición del familiar, el manejo del estrés, la organización de servicios en casa, el apoyo financiero/legal, el transporte, derivaciones a especialistas y acceso a respiro o suplencia de cuidado. Además, el estudio plantea que los resultados de la checklist deben conectarse con opciones de remisión o apoyo con otros profesionales como trabajo social, redes de cuidadores informales, cuidado y atención en salud en el hogar y documentarse en sistemas clínicos estandarizados. En otras palabras, la primera activación efectiva no es solo "detectar riesgo", sino convertirlo en plan de respuesta documentado y con puerta de entrada a servicios concretos.

En la misma dirección, Wangler Et Al muestran que el primer contacto y el primer nivel pueden ser un nodo central para sostener el cuidado en casa, pero solo si deja de esperar a que el cuidador pida ayuda y pasa a un modelo de acercamiento temprano y mediación activa(17). Los hallazgos son muy consistentes, sobre el rol de los equipos de práctica quienes deben identificar cuidadores de forma proactiva, registrar señales

de estrés, ofrecer consultas separadas para la persona que se cuida cuando sea necesario, hacer visitas domiciliarias y derivar de forma temprana a servicios de apoyo y respiro. El artículo también insiste en que la carga del cuidador no se resuelve solo con consejo médico; requiere comunicación interprofesional, redes colaborativas, consejería y servicios de apoyo, e incluso la incorporación de gestores de caso como enlace entre médicos, pacientes, cuidadores y otros proveedores. Esto hace que, para riesgo moderado o alto, una respuesta suficiente no sea una única intervención psicoeducativa, sino una coordinación funcional entre atención primaria, servicios sociales/comunitarios y dispositivos de apoyo al cuidado.

Cuando se revisa la evidencia de efectividad de intervenciones, el bloque más robusto es el de intervenciones psicosociales estructuradas. Chen, con base en un metaanálisis en red de 31 ensayos con 4687 participantes, encontró que las intervenciones basadas en mindfulness (MBIs) fueron las más efectivas para reducir sobrecarga global, especialmente en cuidadores de personas con deterioro cognitivo, mientras que la terapia cognitivo conductual (CBT) fue particularmente eficaz en entornos domiciliarios(22). Esta misma revisión concluye que los hallazgos subrayan la necesidad de estrategias contextuales, es decir, ajustadas tanto al perfil clínico de la persona a quien se cuida como al lugar real donde ocurre el cuidado. Esto es clave para el componente B: ante riesgo alto en entorno hogar, la respuesta no debería ser genérica; si el cuidado está fuertemente atravesado por demencia o deterioro cognitivo, las MBI tienen mejor señal; si el problema central es el estrés cotidiano y la resolución de problemas en casa, la CBT en casa parece más pertinente.

La revisión de Camarena Tinoco Et Al. aporta elementos muy operativos para el entorno hogar porque se centra en intervenciones enfermeras. Su conclusión general es que las intervenciones son efectivas para disminuir estrés, ansiedad, depresión y necesidades no satisfechas, y que las más eficaces para reducir la sobrecarga fueron las visitas domiciliarias y las intervenciones psicoeducativas, tanto grupales como individuales(35). Lo relevante de las visitas documentadas por la evidencia, sino que permitían detectar necesidades insatisfechas, priorizarlas, construir un plan de cuidado y sostener seguimiento telefónico o contactos adicionales según necesidad. En el modelo de gestión de caso (HSC-CM), los tres componentes centrales fueron: evaluación exhaustiva para identificar necesidades del cuidador, gestión de casos para asegurar cuidado coordinado e ininterrumpido, y educación desde un grupo multidisciplinario personalizado; este enfoque mejoró sobrecarga, vitalidad, rol social y bienestar general.

En contextos donde el acceso presencial es difícil o el cuidador no puede salir del hogar, la evidencia sobre soporte remoto indica que estas respuestas son útiles, pero con un efecto más modesto. La revisión Cochrane de González-Fraile encontró que las intervenciones remotas con entrenamiento y/o apoyo, comparadas con la provisión de información sola, pueden producir una ligera reducción de sobrecarga y probablemente una ligera mejoría de síntomas depresivos; sin embargo, frente a atención usual o controles inespecíficos, no mostraron ventajas claras en resultados como sobrecarga, depresión o calidad de vida(23). Esto sugiere que el soporte remoto no reemplaza una red fuerte de respuesta, pero sí puede funcionar como componente complementario de la activación. Estrategias como el seguimiento telefónico, soporte por internet, educación a distancia y contacto frecuente tienen bajo impacto y se deben elegir cuando no hay posibilidad de atención cara a cara. Es estudio de Egan et al. Identifica que existe un beneficio en salud mental de cuidadores reportado con estas estrategias, aunque con alta heterogeneidad metodológica(33).

En condiciones específicas de salud de la persona que se cuida como en situaciones de deterioro cognitivo leve, Domingues muestra que no todos los cuidadores en riesgo requieren la misma intensidad. Para niveles intermedios puede ser suficiente una combinación de educación, apoyo telefónico y materiales estructurados; cuando hay síntomas emocionales o mayor desorganización del cuidado, conviene sumar resolución de problemas y acompañamiento más intensivo(26).

En enfermedad oncológica, Jadalla clasifica como recomendadas para la práctica las intervenciones psicoeducativas, las de apoyo o soporte al cuidado y las cognitivo-conductuales(32). Esta misma revisión, también clasifica como "probablemente efectivas" el entrenamiento de habilidades, la toma de decisiones compartidas, el mindfulness, las intervenciones multicomponente y algunos modelos de cuidados paliativos(32). En términos generales, la evidencia muestra que algunas respuestas efectivas no buscan solo reducir la sobrecarga, sino mejorar la participación del cuidador en decisiones, reducir incertidumbre y aumentar satisfacción con el proceso de cuidado.

8.4 Pregunta 4.

En cuidadores familiares o informales de personas con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿qué estrategias estructuradas de educación y apoyo dirigidas al cuidador incrementan la preparación, la autoeficacia y la competencia para ejercer el rol cuidador, y de qué manera contribuyen a la sostenibilidad del cuidado en casa?

Síntesis de la evidencia:

La evidencia revisada muestra que las estrategias que mejor favorecen el rol del cuidador familiar o informal en el entorno hogar no corresponden a acciones aisladas, sino a intervenciones estructuradas que combinan educación, apoyo psicosocial, entrenamiento en habilidades concretas y mecanismos de seguimiento. Este patrón aparece de manera consistente en revisiones sobre demencia, cuidados paliativos, enfermedad crónica, alfabetización en salud del cuidador y apoyos digitales al cuidado.

Un primer hallazgo es que la educación estructurada sí contribuye a mejorar dimensiones centrales del rol cuidador, especialmente cuando se orienta a necesidades concretas del cuidado en casa y no se limita a entregar información general. Los estudios incluidos en la revisión de Yuen muestran que las intervenciones se han concentrado principalmente en mejorar la comprensión de la enfermedad, el tratamiento, los posibles desenlaces, el cuidado cotidiano, el autocuidado del cuidador y su interacción con los servicios de salud(42).

La revisión de Saucedo Et Al. refuerza este punto al señalar que la necesidad más reportada por los cuidadores de personas dependientes es la falta de educación y entrenamiento sobre el cuidado, y que las intervenciones educativas pueden mejorar conocimientos, competencia y habilidades para el cuidado en cuidadores informales de personas en condición de cronicidad(43). Además, esta revisión fue diseñada específicamente para sintetizar intervenciones educativas orientadas a mejorar la adopción del rol del cuidador familiar de personas dependientes.

En este sentido, la educación más útil para el rol cuidador parece ser aquella que incluye contenidos aplicados, como reconocimiento de signos y complicaciones, cuidado cotidiano, interacción con servicios, autocuidado y resolución de problemas frecuentes del hogar. Yuen destaca que los dominios más trabajados por las intervenciones han sido la comprensión de la enfermedad y del cuidado diario, mientras que Oyola subraya que este tipo de educación se relaciona con mejoría de conocimientos, competencia y habilidad para cuidar(42,43).

Un segundo hallazgo, particularmente consistente, es el valor de las intervenciones multicomponente. La revisión de Chi Et Al. sobre intervenciones conductuales y educativas para cuidadores al final de la vida concluye que todas las intervenciones incluidas tenían una estructura definida y manuales de tratamiento y que mejoraron resultados del cuidador; además, las intervenciones cognitivo-conductuales mostraron resultados más positivos que las educativas o psicoeducativas simples(44).

Dentro de esas intervenciones multicomponente, los estudios resumidos por Chi muestran que los programas psicoeducativos con visitas domiciliarias y llamadas de seguimiento mejoraron competencia, ansiedad y recompensas del cuidado, y que los programas grupales de varias sesiones mejoraron preparación, competencia, recompensas y necesidades informativas(44). En particular, los programas de Hudson Et Al. con dos visitas domiciliarias y llamada de seguimiento, o con tres sesiones grupales consecutivas, mostraron beneficios en preparación, competencia y necesidades informativas del cuidador(45).

La evidencia también respalda el entrenamiento práctico en tareas específicas como un componente clave para fortalecer la competencia del rol cuidador. La revisión de Wagle et al. sobre intervenciones centradas en el cuidador para optimizar la seguridad de la medicación en adultos mayores vulnerables identificó mejoras en autoeficacia, confianza y preparación en varias intervenciones educativas y de entrenamiento, aunque los efectos sobre resultados clínicos finales fueron menos consistentes(46).

De manera complementaria, la revisión de Weir y cols. sobre entrenamiento a cuidadores informales en tareas de movilidad funcional en personas con diagnósticos neurológicos concluye que existe evidencia inicial de que este entrenamiento puede reducir sobrecarga y contribuir a un entorno hogar más seguro(47). Esta revisión es relevante porque muestra que la educación no solo transmite información, sino que puede desarrollar habilidades prácticas observables en tareas de transferencia, movilidad y seguridad.

La dimensión psicoemocional aparece como otro componente esencial. La revisión de Chi muestra que las intervenciones cognitivo-conductuales mejoraron salud psicológica, adaptación, autoeficacia y calidad de vida del cuidador, mientras que las psicoeducativas también reportaron beneficios sobre salud, ansiedad, competencia y necesidades(44). Esto sugiere que fortalecer el rol cuidador no depende únicamente de enseñar tareas, sino también de reducir el impacto emocional del cuidado y fortalecer recursos de afrontamiento.

La revisión de Yuen agrega que la alfabetización en salud del cuidador es protectora no solo para la persona cuidada, sino también para el propio cuidador, particularmente frente a estrés y el esfuerzo. Sin embargo, la misma revisión concluye que la evidencia sobre intervenciones de alfabetización en salud para cuidadores todavía es escasa, con pocos estudios de evaluación pre-post y resultados heterogéneos(42).

Además, Yuen muestra que las intervenciones disponibles en los estudios incluidos en la revisión han cubierto sobre todo cuatro áreas: comprensión

de la enfermedad, comprensión del cuidado cotidiano, autocuidado y relación con proveedores. En contraste, pocas intervenciones han abordado suficientemente aspectos como la relación cuidador–persona cuidada, el acceso a apoyos prácticos, el apoyo financiero/legal o el apoyo social. De igual forma, Yuen señala que los componentes con mayor potencial para mejorar alfabetización en salud del cuidador incluyen información adaptada a las necesidades del grupo cuidador, modalidades mixtas con participación de profesionales y múltiples sesiones(42). También resalta que los cuidadores necesitan acceso a apoyos formales, información sobre servicios disponibles, apoyo práctico y apoyo social para reducir sobrecarga y evitar burnout(42).

En relación con las modalidades digitales y remotas, la actualización de Zhai aporta evidencia muy relevante. Esta revisión identificó 40 estudios y concluyó que más del 85% reportaron mejorías significativas en resultados en salud del cuidador. Los beneficios descritos incluyen reducción de ansiedad, depresión, stress, esfuerzo, sobrecarga y aislamiento; mejoría de autoeficacia, resiliencia, comfort, habilidades de cuidado, calidad de vida, apoyo social y adaptación para el abordaje de complicaciones (48).

Zhai también muestra que la mayoría de las intervenciones digitales combinan educación, comunicación en tiempo real, apoyo, psicoterapia y, en algunos casos, monitoreo o recolección de datos. En otras palabras, la ventaja de la modalidad digital no parece residir solo en el canal tecnológico, sino en su capacidad para integrar varios componentes de apoyo y acercarlos al entorno hogar(48).

No obstante, la evidencia sobre intervenciones digitales también sugiere cautela. La revisión de Yu sobre programas de psicoeducación por internet para cuidadores de personas con demencia encontró efectos significativos sobre síntomas depresivos y estrés, pero no sobre calidad de vida, ansiedad o sobrecarga. Además, los autores plantean que la reducción de burden y ansiedad probablemente requiere enfoques múltiples, que incluyan no solo psicoeducación, sino también apoyo emocional, instrumental, consejería y grupos de pares(49).

Esto coincide con la revisión Cochrane de Corry et al. sobre intervenciones telefónicas o remotas, que mostró efectos modestos o inconsistentes sobre varios resultados, aunque con cierta señal positiva en preparación y apoyo(50). En conjunto, estos hallazgos sugieren que las modalidades digitales y remotas son valiosas para ampliar acceso, continuidad y seguimiento, pero no necesariamente sustituyen por completo a intervenciones más intensivas cuando el cuidador enfrenta alta carga o necesidades complejas (por ejemplo, alta dependencia o síntomas

conductuales de la persona cuidada, deterioro de la salud del cuidador, ausencia de relevo o riesgo para la seguridad).

Otro aspecto reiterado en la evidencia es la importancia del apoyo social, el apoyo práctico y la articulación con recursos. Yuen destaca que muy pocas intervenciones trabajan de forma suficiente el acceso a sistemas de soporte, incluyendo apoyo financiero/legal, apoyo práctico y apoyo social, a pesar de que estos factores son relevantes para el bienestar del cuidador y para evitar sobrecarga y burnout.

La evidencia contextual revisada en el estudio de Sulino y cols. coincide con que en cuidadores familiares de niños y adolescentes con necesidades complejas, el apoyo social y el relevo aparecen como fundamentales para sostener el cuidado, mientras que la falta de preparación para la atención domiciliaria, la información insuficiente durante el alta y la débil conexión entre servicios incrementan la inseguridad del cuidador y afectan la continuidad del cuidado en el hogar(51).

En conjunto, la evidencia permite concluir que las estrategias con mejor soporte para fortalecer el rol cuidador en casa son: educación estructurada, psicoeducación, entrenamiento práctico en habilidades, apoyo emocional o cognitivo-conductual, intervenciones multicomponente con seguimiento, apoyo grupal o entre pares, y modalidades digitales o remotas como complemento de acceso y continuidad.

La evidencia es más sólida para resultados como preparación, conocimientos, competencia práctica, autoeficacia en tareas específicas, sobrecarga, ansiedad, depresión, adaptación y apoyo social que para demostrar directamente la sostenibilidad del cuidado en casa como desenlace final. Sin embargo, varios textos convergen en que una menor sobrecarga, una mayor competencia, mejor autoconfianza, mejor acceso a apoyos y mayor capacidad de resolución de problemas son condiciones que favorecen esa sostenibilidad.

Desde la perspectiva operativa del lineamiento, esta síntesis respalda un enfoque escalonado. Todos los cuidadores deberían acceder a un componente básico de educación y entrenamiento orientado al cuidado cotidiano en casa; quienes presenten mayor inseguridad, sobrecarga o dificultad para sostener el rol deberían recibir además psicoeducación, apoyo emocional y seguimiento; y los casos de mayor complejidad deberían contar con intervenciones multicomponente, entrenamiento específico y articulación con redes y apoyos formales. Esta orientación es coherente con la evidencia revisada y también con la lógica del PICF, que reconoce que el bienestar del cuidador fortalece su rol y favorece la sostenibilidad del cuidado en el tiempo.

9. Pautas de cuidado preliminares para el abordaje integral del cuidador familiar o informal en el entorno hogar.

9.1 Generales

- En las acciones dirigidas a mujeres cuidadoras se recomienda incorporar el marco de las 5R del cuidado, procurando reconocer el valor y los efectos del trabajo de cuidado, reducir las cargas evitables, redistribuir las responsabilidades de cuidado y favorecer condiciones de protección, participación y acceso a apoyos, evitando que las intervenciones refuercen la concentración del cuidado en una sola persona.

- En toda familia en la que una o más personas requieran apoyo continuo por enfermedad crónica, discapacidad, dependencia funcional, deterioro cognitivo, enfermedad avanzada u otra necesidad de cuidado, se recomienda identificar explícitamente quiénes ejercen el cuidado principal, secundario u ocasional. El cuidador debe reconocerse como sujeto de valoración y cuidado dentro del Plan Integral de Cuidado Familiar, y no únicamente como recurso para atender a otro integrante de la familia. Durante esta identificación se recomienda indagar si el propio cuidador presenta una condición de salud de base, discapacidad, enfermedad crónica o trastorno mental que dificulte su autocuidado o su capacidad para cuidar; esta situación debe registrarse y considerarse un criterio de mayor riesgo en la clasificación.

- Se recomienda realizar la valoración del cuidador desde un enfoque familiar y contextual, integrando las condiciones de la persona cuidada, las capacidades y necesidades del cuidador, la distribución de responsabilidades dentro de la familia, la red de apoyo, las condiciones económicas, las barreras territoriales y la disponibilidad de servicios. No se recomienda interpretar la situación del cuidador de manera aislada del sistema familiar y del entorno donde ocurre el cuidado.

- Se recomienda que los resultados de la valoración del cuidador se incorporen al plan de cuidado familiar mediante problemas o necesidades priorizadas, objetivos, acciones, responsables, apoyos requeridos, criterios de seguimiento y condiciones para intensificar

la respuesta. La identificación de una necesidad sin una acción, responsable o mecanismo de seguimiento no debe considerarse una respuesta completa. El mecanismo de seguimiento debe incluir indicadores de resultado para el cuidador, como el cambio en la sobrecarga y en la preparación, y la verificación del acceso a los apoyos gestionados.

- Se recomienda que las acciones dirigidas al cuidador sean acordadas con él y con la familia, respetando su autonomía, preferencias, disponibilidad, características culturales, alfabetización en salud, condiciones territoriales y acceso a tecnologías. La adaptación al contexto no debe eliminar los componentes esenciales de identificación, educación, apoyo, seguimiento y activación de redes.

- Se recomienda incorporar dentro de las acciones de acompañamiento familiar la orientación a los cuidadores para su reconocimiento y registro, de acuerdo con los lineamientos vigentes del Ministerio de Salud y Protección Social para el fortalecimiento de las acciones dirigidas a las personas cuidadoras. Esto permitirá avanzar en su visibilización y facilitar su acceso a futuras estrategias, programas y beneficios dirigidos a esta población.

- En familias con personas con discapacidad y cuidadores familiares o informales, se recomienda fortalecer la implementación de la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) como marco para promover la inclusión social, el ejercicio de derechos, la participación, el fortalecimiento de redes familiares y comunitarias y la articulación con servicios y apoyos de salud, rehabilitación, educación, protección social y otros sectores. Cuando se identifiquen barreras de acceso, aislamiento, sobrecarga del cuidador o insuficiencia de apoyos, se recomienda activar y hacer seguimiento a las redes institucionales, comunitarias e intersectoriales disponibles.

- Para efectos de esta pauta, se entiende por cuidador familiar o informal principal a la persona de la familia o del entorno cercano que, sin remuneración, asume la mayor parte del tiempo, las tareas y la responsabilidad del cuidado de forma regular. Cuando dos o más personas comparten el cuidado (por ejemplo, dos hermanas que conviven con la madre), la valoración completa se recomienda realizarla a quien asuma la mayor dedicación y responsabilidad; si la carga se distribuye de manera similar, se recomienda valorar a ambas personas y registrar la distribución de tareas. Los cuidadores

secundarios deben recibir al menos la identificación inicial y la educación básica.

9.2 Pautas pregunta 1. Identificación del rol cuidador, valoración de la sobrecarga y clasificación del riesgo

- Identificación proactiva del rol cuidador

- En el primer contacto con una familia que tenga una persona con necesidades de cuidado, se recomienda identificar proactivamente al cuidador, sin esperar a que este se reconozca como tal o solicite ayuda. Se debe preguntar, como mínimo: quién realiza la mayor parte del cuidado; qué tareas asume; cuántas horas dedica; desde cuándo cuida; si comparte el cuidado; si dispone de relevo; y qué cambios ha producido el cuidado en su salud, trabajo, estudio, descanso, relaciones y vida cotidiana.

- Si varias personas participan en el cuidado, se recomienda diferenciar el cuidador principal, los cuidadores secundarios y las personas que podrían asumir relevo. La valoración debe identificar si la distribución del cuidado es suficiente, inequitativa, inestable o dependiente de una sola persona.

- Se recomienda utilizar preguntas breves o una lista de verificación como primera fase de identificación. Esta valoración inicial debe explorar el contexto del cuidado, las tareas realizadas, las capacidades y preocupaciones del cuidador, la dependencia de la persona cuidada y los apoyos disponibles. La lista de verificación no sustituye la medición de sobrecarga cuando existan señales de riesgo.

- Las preguntas mínimas de esta primera fase son las señaladas en la recomendación inicial: quién realiza la mayor parte del cuidado; qué tareas asume; cuántas horas dedica al día y a la semana; desde cuándo cuida; si comparte el cuidado o dispone de relevo; y qué cambios ha producido el cuidado en su salud, sueño, trabajo, estudio, ingresos, relaciones y vida cotidiana. La lista de verificación debe incluir además: nivel de dependencia y problemas conductuales de la persona cuidada; tareas de riesgo (medicamentos, dispositivos, movilización); preocupaciones y necesidades de información del cuidador; señales de cansancio, estrés o malestar emocional; apoyos y servicios disponibles; y señales de alarma de seguridad o violencia. La presencia de

cualquiera de estas señales debe conducir al tamizaje de sobrecarga.

- Si el cuidador refiere no considerarse cuidador, pero realiza supervisión, apoyo físico, administración de medicamentos, acompañamiento a servicios, gestión económica, apoyo emocional o tareas domésticas indispensables para otra persona, se recomienda reconocer y registrar la existencia del rol cuidador y valorar sus efectos.

- Tamizaje y medición de la sobrecarga

- Una vez identificado el cuidador, se recomienda realizar un tamizaje de sobrecarga cuando el cuidado sea frecuente o prolongado, exista dependencia funcional, se presenten problemas conductuales, haya ausencia de relevo o el cuidador refiera cansancio, estrés, afectación de su salud o dificultades para continuar cuidando.

- Se considera cuidado frecuente el que se realiza a diario o la mayor parte de los días de la semana, o que exige supervisión o disponibilidad nocturna; y cuidado prolongado, el que se ha mantenido de manera continua durante seis meses o más, o cuya duración previsible es igual o mayor a ese tiempo (orientación operativa por consenso del equipo técnico, a validar en el procedimiento territorial). La evidencia identifica la duración y la intensidad del cuidado como predictores de sobrecarga, pero no establece un umbral único; por ello, estos criterios no deben impedir el tamizaje cuando existan otras señales de riesgo.

- Para la valoración inicial de sobrecarga en cuidadores familiares o informales adultos, principalmente de personas con dependencia, enfermedad crónica o deterioro cognitivo, puede utilizarse el Zarit Burden Interview (ZBI) en una versión validada para el idioma, población y contexto de aplicación. Su interpretación debe realizarse con los puntos de corte correspondientes a la versión utilizada y no mediante umbrales extrapolados de otras validaciones.

- El ZBI se recomienda como herramienta base cuando se requiera una medición ampliamente conocida, breve, con múltiples validaciones y posibilidad de seguimiento. No se recomienda usarlo como único indicador del estado emocional, físico, familiar o social del cuidador, ni asumir que sus propiedades son iguales en todos

los tipos de cuidadores. En el contexto del PICF, y en concordancia con la Resolución 3280 de 2018, el ZBI se recomienda como instrumento de primera elección para valorar la sobrecarga del cuidador, complementado con los instrumentos de valoración familiar (familiograma, ecomapa y APGAR familiar).

- Cuando se requiera una alternativa breve, sencilla y susceptible de autoadministración y seguimiento periódico, puede considerarse la Burden Scale for Family Caregivers en su versión corta —BSFC-s, siempre que se disponga de una versión lingüística y culturalmente adecuada.

- Si el tamizaje inicial está alterado, el caso es complejo o se necesita identificar en qué dimensiones se concentra la carga, se recomienda complementar la valoración con un instrumento multidimensional como el Caregiver Burden Inventory (CBI). Esta herramienta permite explorar carga emocional, física, social, evolutiva y relacionada con el tiempo, y puede orientar el tipo de apoyo requerido.

- En cuidadores de personas con demencia o deterioro cognitivo puede considerarse el Screen for Caregiver Burden (SCB) cuando se requiera diferenciar los problemas derivados de la conducta de la persona cuidada y los efectos específicos sobre el cuidador. Su uso en otras poblaciones debe ser prudente por la mayor concentración de evidencia en demencia.

- El Caregiver Strain Index —CSI— puede utilizarse como aproximación muy breve al esfuerzo del cuidador cuando no sea posible aplicar una valoración más extensa. No se recomienda como única herramienta para decidir la intensidad de acompañamiento en familias con necesidades complejas.

- Para efectos de esta pauta, se consideran familias o cuidadores con necesidades complejas aquellos en los que coinciden dos o más de las siguientes condiciones: alta dependencia funcional o necesidad de supervisión continua; síntomas conductuales o deterioro cognitivo de la persona cuidada; multimorbilidad, enfermedad avanzada o en fase paliativa; tareas técnicas o de riesgo (dispositivos, administración compleja de medicamentos, movilización frecuente); problemas de salud física o mental del cuidador; ausencia de relevo; dificultades económicas o barreras de acceso a servicios; o señales de violencia o riesgo para la seguridad.

- La selección del instrumento debe responder al objetivo de la valoración. Si se busca estimar carga global puede utilizarse ZBI o BSFC; si se busca perfilar dimensiones y orientar intervenciones específicas, se recomienda CBI o, en demencia, SCB. No se recomienda seleccionar una escala únicamente por familiaridad del equipo si no responde a la decisión clínica o familiar requerida. En todo caso, la selección debe considerar la disponibilidad de versiones validadas en Colombia; mientras no se disponga de estas para otros instrumentos, la clasificación del riesgo debe apoyarse en el ZBI y en la valoración integral descrita en esta pauta.

- Clasificación y seguimiento

- La clasificación del riesgo del cuidador no debe establecerse exclusivamente con el puntaje de una escala. Se recomienda integrar el resultado del instrumento con: dependencia funcional y problemas conductuales de la persona cuidada; duración e intensidad del cuidado; salud física y mental del cuidador; calidad del sueño; dificultades económicas; conflicto de rol; disponibilidad de relevo; apoyo social; resiliencia; afrontamiento y acceso a servicios.

- El riesgo del cuidador es un concepto integral que incluye la sobrecarga medida por el instrumento, pero también el riesgo clínico, psicosocial y de seguridad. Los niveles de riesgo (bajo, moderado, alto y crítico o de seguridad) y sus criterios se precisan en el apartado de estratificación operativa. Así como existen factores que aumentan el riesgo y la frecuencia del seguimiento, la presencia sostenida de factores protectores como el relevo efectivo y estable, apoyo social percibido, uso de servicios, afrontamiento adaptativo, resiliencia, preparación y competencia para las tareas, puede justificar mantener o reducir la intensidad del seguimiento, siempre que no existan síntomas clínicos ni señales de seguridad.

- La pauta de seguimiento debe tener como referencia lo establecido en el lineamiento de PICF de la secretaria de salud.

- Si el puntaje de sobrecarga es bajo, pero existen síntomas depresivos o ansiosos, deterioro físico, dificultades económicas, ausencia de relevo, violencia, aislamiento o incapacidad para garantizar un cuidado seguro, se recomienda clasificar el riesgo según la situación clínica y psicosocial y no según el puntaje aislado.

- Si el cuidador presenta una puntuación elevada de sobrecarga, se recomienda realizar una valoración ampliada de salud mental, salud física, funcionamiento cotidiano, red de apoyo y seguridad del cuidado antes de definir la respuesta. La sobrecarga subjetiva se asocia de manera importante con ansiedad y otros desenlaces adversos y debe considerarse una señal clínica y psicosocial.

- Se recomienda repetir la valoración del cuidador cuando cambie la dependencia o conducta de la persona cuidada, ocurra una hospitalización o alta, se modifique el tratamiento, falle o se retire una persona de apoyo, se prolongue el cuidado, aparezca una crisis familiar, cambie el lugar de residencia o la composición del hogar, o el cuidador refiera deterioro de su salud o dificultad para continuar cuidando.

- El equipo territorial debe definir en su procedimiento la periodicidad del seguimiento para cada nivel de riesgo. La frecuencia debe aumentar cuando se acumulan estresores, disminuyen los factores protectores o cambian las condiciones de cuidado, y no limitarse a una periodicidad uniforme para todas las familias.

9.3 Pautas pregunta 2. Intervenciones estructuradas para proteger la salud del cuidador y favorecer la sostenibilidad del cuidado

- A todo cuidador identificado se recomienda ofrecer una intervención básica que incluya información sobre el rol, autocuidado, reconocimiento de sobrecarga, acceso a apoyos y mecanismos para solicitar ayuda. Cuando exista riesgo moderado o alto, esta intervención debe ampliarse y no limitarse a consejos generales o entrega aislada de material.

- Ampliar la intervención significa pasar de la información general a una intervención estructurada con objetivos definidos a partir de la valoración, más contactos y seguimiento, e incorporar, según la necesidad, psicoeducación, entrenamiento en habilidades prácticas, resolución de problemas, apoyo emocional, organización del relevo y articulación con otros servicios. En el riesgo moderado esta ampliación corresponde a la intervención psicoeducativa estructurada y en el riesgo alto, al plan individualizado con coordinación de apoyos, descritos en el componente de respuesta según el nivel de riesgo.

- En cuidadores con sobrecarga, estrés, necesidades no satisfechas o dificultades para sostener el cuidado, se recomiendan intervenciones psicosociales estructuradas que combinen, según la necesidad, psicoeducación, apoyo emocional, entrenamiento en afrontamiento, resolución de problemas, habilidades prácticas y seguimiento. Las intervenciones multicomponente muestran un patrón de beneficio más consistente que las acciones aisladas.

- Se recomienda que las intervenciones multicomponente partan de una valoración individual del cuidador y definan objetivos concretos, contenidos, número y modalidad de contactos, profesional responsable, acciones de refuerzo y criterios de reevaluación. No se recomienda considerar como intervención estructurada una conversación única sin objetivos ni seguimiento.

- Intervenciones psicológicas y psicosociales.

- En cuidadores con síntomas depresivos, ansiedad, estrés persistente, afrontamiento ineficaz o elevada sobrecarga emocional, se recomienda ofrecer o gestionar intervenciones cognitivo-conductuales, de resolución de problemas o de afrontamiento, ajustadas a la intensidad de los síntomas y a la capacidad del equipo territorial.

- Si el cuidador presenta síntomas depresivos o riesgo de depresión, se recomienda priorizar intervenciones psicológicas focalizadas en depresión y resolución de problemas, en lugar de apoyos genéricos. Las intervenciones breves muestran mejores resultados cuando seleccionan a los cuidadores según el problema clínico que se busca modificar y cuando la intervención tiene un objetivo explícito.

- Las intervenciones basadas en mindfulness pueden considerarse en cuidadores con estrés, depresión o distrés emocional, especialmente en contextos de deterioro cognitivo. No se recomienda utilizarlas como única respuesta cuando el problema principal sea sobrecarga estructural, ausencia de relevo, dificultades económicas o demandas de cuidado no resueltas.

- Las técnicas de relajación, respiración y manejo del estrés pueden incorporarse como componentes de una intervención más amplia. Estas técnicas no deben reemplazar la respuesta frente a necesidades prácticas, clínicas, familiares o sociales que mantienen la sobrecarga.

- Intervenciones de enfermería y proximidad.

- Cuando el cuidador presenta dificultades en la organización cotidiana del cuidado, necesidades no satisfechas o barreras para acudir a los servicios, se recomiendan intervenciones de proximidad, particularmente visitas domiciliarias con valoración, educación, priorización de necesidades, construcción de un plan y seguimiento posterior.

- La evidencia que respalda estas intervenciones proviene principalmente de programas liderados por profesionales de enfermería; en el territorio pueden ser realizadas por el equipo de salud con formación en cuidado familiar, bajo la orientación y supervisión de enfermería.

- La visita domiciliaria dirigida al cuidador debe incluir un espacio específico para escucharle y valorar sus necesidades, y no concentrarse exclusivamente en la condición de la persona cuidada. Cuando sea necesario, se recomienda realizar parte de la entrevista de manera privada para facilitar la identificación de malestar, conflicto, violencia o dificultad para continuar cuidando. La visita constituye, además, una oportunidad para observar la interacción familiar, la distribución real del cuidado, la seguridad del hogar y las condiciones ambientales que pueden incrementar la carga del cuidador, por lo que no debe limitarse a la aplicación de instrumentos.

- Las intervenciones de enfermería deben fortalecer, como mínimo, conocimientos sobre la condición de la persona cuidada, resolución de problemas, comunicación asertiva, autocuidado, reconocimiento de signos de alarma y habilidades para solicitar apoyo. La falta de conocimientos, tiempo personal, redes y habilidades emocionales se asocia con mayor sobrecarga.

- Actividad física y autocuidado.

- Se recomienda promover actividad física adaptada, pausas activas, relajación muscular y recuperación del descanso como componentes del autocuidado del cuidador, especialmente cuando exista inactividad, tensión muscular, estrés o deterioro del

bienestar físico. Estas acciones deben ajustarse a su estado de salud, disponibilidad y preferencias.

- La actividad física no debe presentarse como sustituto de intervenciones psicosociales, relevo, apoyo social o atención clínica cuando estos sean necesarios. Corresponde a un componente complementario dentro de una respuesta integral.

- Modalidades remotas.

- El seguimiento telefónico, virtual o por internet puede utilizarse para reforzar educación, acompañar la aplicación de habilidades, monitorear síntomas y superar barreras geográficas o de disponibilidad. Se recomienda usarlo como complemento de la atención, especialmente en zonas rurales o dispersas.

- No se recomienda sustituir automáticamente las visitas o el acompañamiento presencial por intervenciones remotas en cuidadores con alta sobrecarga, deterioro de salud mental, necesidades complejas, riesgo de violencia o dificultades para usar tecnología. En comparación con la atención usual, los efectos de las intervenciones remotas sobre sobrecarga, depresión y calidad de vida son pequeños o inconsistentes.

- Cuando se utilicen intervenciones remotas, se recomienda verificar acceso a dispositivo, conectividad, alfabetización digital, privacidad, comprensión de contenidos, posibilidad de contacto alternativo y criterios para cambiar a atención presencial.

- Adaptación a condiciones clínicas.

- En cuidadores de personas con demencia o deterioro cognitivo, se recomienda incorporar educación sobre síntomas conductuales, comunicación, estructuración de rutinas, seguridad y afrontamiento; las intervenciones psicosociales, multicomponente, de mindfulness o cognitivo-conductuales pueden seleccionarse de acuerdo con el problema predominante.

- En cuidadores de personas con enfermedad oncológica avanzada o necesidades paliativas, se recomienda integrar psicoeducación, apoyo a la toma de decisiones, manejo de incertidumbre, apoyo

emocional, entrenamiento en habilidades y vinculación temprana con cuidados paliativos cuando esté indicado.

- En cuidadores de personas con disnea crónica, producto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca, asma grave u otras enfermedades de alta demanda (entendidas como aquellas con alta carga de síntomas, exacerbaciones o crisis frecuentes, dependencia de oxígeno u otros dispositivos y necesidad de cuidados diarios complejos), se recomienda incorporar habilidades para el manejo de síntomas, prevención de crisis, afrontamiento del estrés y organización familiar del cuidado. Estas intervenciones pueden reducir carga, estrés y depresión y mejorar la función familiar y la confianza del cuidador.

- En condiciones con evidencia limitada, como deterioro cognitivo leve o tumores cerebrales y medulares, se recomienda individualizar la intervención y comunicar que la certeza sobre los efectos es menor. Pueden considerarse educación, resolución de problemas, organización de rutinas, apoyo telefónico y acompañamiento psicosocial.

- Evaluación de resultados.

- Se recomienda evaluar la respuesta de las intervenciones mediante desenlaces del cuidador, como sobrecarga, síntomas depresivos y ansiosos, estrés, salud física, preparación, autoeficacia, función familiar y necesidades no satisfechas. No se recomienda evaluar el éxito únicamente por la estabilidad clínica de la persona cuidada.

- La sostenibilidad del cuidado en casa debe valorarse mediante indicadores directos e indirectos: capacidad expresada para continuar cuidando, disponibilidad de relevo, disminución de sobrecarga, mayor preparación, mejor función familiar, continuidad del cuidado seguro, uso adecuado de apoyos y ausencia de institucionalización no planificada. La evidencia sobre desenlaces directos de sostenibilidad es limitada, por lo que deben interpretarse conjuntamente varios indicadores.

9.4 Pautas pregunta 3. Componente A. Identificación y estratificación del riesgo clínico, psicosocial y de seguridad.

- Evaluación de la complejidad de la persona cuidada

- En toda valoración del cuidador se recomienda explorar el nivel de dependencia de la persona cuidada en actividades básicas e instrumentales, la necesidad de supervisión, la multimorbilidad, el deterioro cognitivo, los problemas conductuales y las alteraciones del sueño o de la memoria. La mayor dependencia y los problemas conductuales son los determinantes más consistentes de sobrecarga.

- Si la persona cuidada presenta agitación, agresividad, irritabilidad, delirios, apatía, deambulación problemática, conducta motora aberrante, alteración severa del sueño u otros síntomas neuropsiquiátricos, se recomienda valorar de forma prioritaria el distrés, agotamiento, capacidad de afrontamiento y seguridad del cuidador.

- Cuando el cuidado requiera supervisión constante, movilización frecuente, manejo de dispositivos, administración compleja de medicamentos o respuesta repetida a crisis, se recomienda considerar la demanda objetiva del cuidado como criterio de aumento del riesgo, incluso si el cuidador minimiza su malestar.

- Evaluación psicosocial y estructural del rol.

- Se recomienda valorar duración del cuidado, horas diarias y semanales, disponibilidad nocturna, número y complejidad de tareas, interrupción del sueño, pérdida de empleo o estudio, reducción de ingresos, gastos asociados, aislamiento, conflicto familiar y ausencia de tiempo personal. Estos factores se acumulan y anticipan mayor riesgo.

- Si el cuidado depende de una sola persona y no existe relevo efectivo, se recomienda considerar esta condición como un factor de aumento del riesgo, especialmente cuando se combina con alta dependencia, enfermedad conductual, problemas económicos o deterioro del cuidador.

- La existencia nominal de familiares no debe asumirse como red efectiva. Se recomienda verificar quién puede ayudar, con qué tareas, en qué horarios, con qué frecuencia y bajo qué condiciones. El ecomapa u otras herramientas de lectura de red pueden utilizarse

para diferenciar apoyos disponibles, débiles, conflictivos o inexistentes.

- Se recomienda valorar los factores protectores y activos para la salud del cuidador y de su familia, como apoyo familiar percibido, relevo, uso de servicios, resiliencia, afrontamiento adaptativo, autoeficacia, preparación y competencia. La presencia de estos factores y activos puede moderar el riesgo, pero no debe utilizarse para minimizar síntomas clínicos o de seguridad.

- Evaluación clínica de la persona que cuida

- Se recomienda preguntar de forma directa por síntomas depresivos, ansiedad, irritabilidad, desesperanza, estrés persistente, agotamiento, alteraciones del sueño, dolor, cansancio, deterioro de enfermedades preexistentes y mala salud autopercibida. La presencia de estos síntomas debe incrementar la clasificación del riesgo al menos al nivel moderado y, si son persistentes, intensos o se acompañan de deterioro funcional, al nivel alto, de acuerdo con los criterios de la estratificación operativa.

- Si el cuidador refiere sentirse exhausto, no poder continuar, perder el control, no dormir, descuidar su alimentación, abandonar tratamientos propios o experimentar deterioro rápido de su salud, se recomienda realizar una valoración clínica prioritaria y no limitar la respuesta a educación o recomendaciones de autocuidado.

- Se recomienda indagar si el cuidador ha aumentado el uso de consultas, urgencias, medicamentos, alcohol u otras sustancias para enfrentar el cuidado. Cuando se identifiquen conductas que puedan agravar el riesgo clínico o comprometer la seguridad, se debe activar la atención correspondiente mediante la ruta integral de atención en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas de la entidad responsable del aseguramiento, con valoración médica o psicológica prioritaria y registro de la remisión con cierre de ciclo, de acuerdo con las rutas integrales de atención en salud vigentes.

- Riesgo de violencia y seguridad

- Se recomienda explorar de manera respetuosa y, cuando sea posible, privada la presencia de gritos, amenazas, humillaciones, negligencia, abandono, restricción, agresión física o sexual,

explotación económica o temor dentro de la relación de cuidado. La evidencia disponible no establece un umbral único para violencia, por lo que debe prevalecer el principio de protección. Ante sospecha de violencia se recomienda activar la ruta de atención integral a víctimas de violencias del municipio: atención en salud con notificación al Sivigila (evento 875, violencia de género e intrafamiliar), remisión a comisaría de familia (Ley 2126 de 2021) y, cuando la víctima sea la persona mayor, aplicación de las medidas de protección previstas en la Ley 1251 de 2008.

- Si coinciden agotamiento severo, deterioro de la salud mental, ausencia de relevo, afrontamiento ineficaz y síntomas conductuales agresivos o desorganizados de la persona cuidada, se recomienda considerar la situación como alarma de seguridad y realizar una valoración clínica, familiar y psicosocial intensiva.

- Si existe riesgo inminente para la integridad del cuidador, de la persona cuidada o de otros integrantes del hogar, se recomienda no dejar la respuesta para un seguimiento rutinario y activar de inmediato los mecanismos territoriales de urgencias, salud mental, protección y apoyo social aplicables.

- Explorar en la persona cuidada, en especial en población "vulnerable" discapacidad, Niños, Niñas y Adolescentes, explore de manera integral Abuso Sexual Infantil.

- Estratificación operativa

- Se recomienda clasificar como riesgo bajo al cuidador sin síntomas clínicos relevantes, con carga leve o ausente, salud estable, demandas manejables, apoyo disponible y relevo suficiente. En este nivel se debe mantener educación básica, promoción del autocuidado y seguimiento periódico de acuerdo con el lineamiento de PICF.

- Se recomienda clasificar como riesgo moderado cuando exista uno o más estresores relevantes, entre ellos: dependencia creciente, carga leve o moderada persistente, reducción del autocuidado, síntomas emocionales iniciales, alteraciones del sueño, tensión económica o apoyo insuficiente, sin evidencia de colapso o peligro inmediato. Este nivel requiere intervención preventiva estructurada, idealmente de cuatro a ocho sesiones o contactos

individuales o grupales, y seguimiento más cercano, al menos mensual.

- Se recomienda clasificar como riesgo alto cuando se acumulen varios predictores: síntomas depresivos o ansiosos, mala salud autopercibida, agotamiento, cuidado prolongado o de alta intensidad, ausencia de relevo, dificultades financieras, aislamiento y alta dependencia o problemas conductuales de la persona cuidada. Este nivel requiere valoración ampliada, plan individualizado y coordinación de apoyos.

- Se recomienda clasificar como riesgo crítico o de seguridad cuando exista desborde severo, incapacidad para continuar garantizando el cuidado, deterioro rápido de la salud física o mental, violencia actual o probable, abandono, ausencia completa de relevo o problemas conductuales graves que comprometan la integridad de las personas. En este nivel se requiere activación inmediata de respuesta clínica y psicosocial.

- Se recomienda revisar la clasificación después de cada intervención o cambio significativo. Un cuidador puede pasar rápidamente de riesgo moderado a alto o crítico cuando pierde un apoyo, cambia la condición de la persona cuidada o se deteriora su propia salud.

- Se considera cambio significativo, entre otros: hospitalización, alta o consulta de urgencias de la persona cuidada; aumento de la dependencia o aparición de nuevos síntomas conductuales; inicio de tareas técnicas o de nuevos medicamentos; pérdida o retiro de una persona de relevo; cambio de residencia o de la composición del hogar; pérdida de empleo o ingresos; aparición o empeoramiento de enfermedad o síntomas emocionales en el cuidador; y cualquier señal de violencia o de incapacidad para continuar cuidando.

9.5 Componente B. Respuesta y activación intersectorial según el nivel de riesgo

- En todos los niveles de riesgo, la unidad de atención es la familia. Además de las acciones dirigidas al cuidador, la respuesta debe orientarse a redistribuir las responsabilidades de cuidado, fortalecer las redes de apoyo y promover la corresponsabilidad de los demás integrantes de la familia y del entorno.

- Se recomienda que, cuando durante las visitas familiares se identifiquen personas con discapacidad que no cuenten con certificación, se realice la orientación y canalización correspondiente hacia el procedimiento de certificación de discapacidad, en cumplimiento de la Resolución 1197 de 2024, como mecanismo para el reconocimiento oficial de la discapacidad y la garantía de derechos.

- Respuesta para riesgo bajo

- En cuidadores clasificados en riesgo bajo se recomienda ofrecer educación básica sobre el rol, autocuidado, signos de sobrecarga, organización familiar del cuidado, recursos disponibles y formas de solicitar ayuda. Se debe establecer un momento de reevaluación, al menos cada seis meses o antes si ocurre un cambio significativo, y no asumir que el riesgo permanecerá estable.

- Se recomienda promover la distribución anticipada de tareas, la identificación de personas de relevo y la preparación de un plan familiar para situaciones de enfermedad, ausencia o agotamiento del cuidador principal.

- Respuesta para riesgo moderado

- En cuidadores con riesgo moderado se recomienda implementar una intervención psicoeducativa estructurada, individual o grupal, que responda a las necesidades identificadas e incluya seguimiento presencial, telefónico o virtual. La entrega aislada de información no se considera suficiente.

- Se recomienda incorporar resolución de problemas, manejo del estrés, fortalecimiento de habilidades, reorganización de tareas familiares y vinculación con grupos de apoyo, redes comunitarias o servicios de relevo disponibles.

- Si existen necesidades económicas, legales, de transporte, alimentación, ayudas técnicas, acceso a servicios o trámites, se recomienda gestionar la remisión o articulación con trabajo social y con los actores territoriales competentes. La respuesta debe quedar registrada y verificarse si el cuidador logró acceder al apoyo.

- Respuesta para riesgo alto

- En cuidadores con riesgo alto se recomienda realizar una valoración integral y elaborar un plan individualizado de respuesta que incluya, según el caso, atención clínica, salud mental, intervención de enfermería, trabajo social, apoyo comunitario, respiro, atención domiciliaria y educación específica.

- Se recomienda designar un profesional o gestor responsable de coordinar el caso cuando intervengan múltiples servicios. Su función debe incluir consolidar necesidades, gestionar remisiones, facilitar comunicación entre actores, verificar acceso y actualizar el plan de cuidado familiar.

- Cuando exista depresión, ansiedad clínicamente relevante, estrés intenso, alteración del sueño o deterioro funcional del cuidador, se recomienda activar atención de salud mental y mantener simultáneamente acciones sobre los factores familiares y sociales que sostienen la sobrecarga.

- Cuando la persona cuidada tenga enfermedad avanzada o en fase paliativa, se recomienda articular tempranamente con cuidados paliativos y ofrecer apoyo para decisiones, manejo de síntomas, anticipación de crisis y acompañamiento emocional del cuidador.

- Si el cuidador no puede desplazarse, se recomienda priorizar visita domiciliaria o combinarla con seguimiento remoto. Las modalidades remotas no deben convertirse en la única respuesta cuando persisten alta complejidad, deterioro clínico o riesgo de seguridad.

- Respuesta para riesgo crítico o de seguridad

- Si se identifica riesgo inminente de violencia, autolesión, daño a terceros, abandono, negligencia grave o incapacidad para mantener condiciones básicas de seguridad, se recomienda activar inmediatamente las rutas territoriales de urgencias, salud mental, protección y respuesta social, de acuerdo con la población y la normativa vigente.

- En situaciones críticas se recomienda acordar un plan inmediato de seguridad que defina: quién acompañará al cuidador y a la persona cuidada; quién asumirá temporalmente el cuidado; qué servicio

recibirá la remisión; cómo se realizará el traslado si se requiere; y quién verificará la recepción y continuidad de la atención.

- Si no existe una persona de relevo y el cuidador no puede continuar de manera segura, se recomienda gestionar una alternativa temporal de cuidado mediante la red familiar, comunitaria, social o institucional disponible. No se debe mantener el cuidado exclusivamente a cargo de una persona en colapso.

- La sospecha de violencia o vulneración de derechos debe documentarse con lenguaje objetivo, preservando la confidencialidad y evitando confrontaciones que aumenten el riesgo. Se deben aplicar las rutas y competencias legales y territoriales correspondientes.

- Mecanismos de articulación

- Se recomienda que la articulación intersectorial parta de una necesidad concreta y no de remisiones genéricas. Cada remisión debe precisar el problema identificado, la acción requerida, el nivel de urgencia y el responsable de verificar su cumplimiento.

- El plan de cuidado familiar debe integrar, según disponibilidad territorial, atención primaria, enfermería, medicina, psicología, trabajo social, salud mental, rehabilitación, cuidados paliativos, servicios sociales, redes comunitarias, grupos de cuidadores, mecanismos de protección y programas de respiro o apoyo domiciliario.

- Se recomienda utilizar mecanismos de referencia con cierre de ciclo: registrar la remisión, confirmar la recepción, conocer la respuesta del servicio y actualizar el plan. La simple entrega de un número telefónico o dirección no garantiza la articulación.

- Los municipios y prestadores deben adaptar este lineamiento mediante un directorio actualizado de servicios y rutas que especifique contactos, horarios, criterios de acceso y responsables. El equipo que realiza la visita debe conocer qué apoyos existen realmente en el territorio.

- Cuando los servicios formales sean limitados, se recomienda identificar recursos comunitarios, organizaciones sociales, redes de vecinos, asociaciones de pacientes, grupos religiosos u otros apoyos aceptados por la familia, sin trasladar a estos actores

responsabilidades clínicas o de protección que corresponden al Estado o al sistema de salud.

Tabla 4. Resumen de la respuesta según el nivel de riesgo del cuidador

Nivel de riesgo	**Criterios principales**	**Respuesta**	**Seguimiento mínimo de referencia**
Bajo	Sin síntomas clínicos relevantes; sobrecarga leve o ausente; buen apoyo y relevo; demandas de cuidado manejables.	Educación básica sobre el rol, autocuidado, signos de sobrecarga y recursos; distribución anticipada de tareas; plan familiar ante contingencias.	Reevaluación al menos cada seis meses o antes si ocurre un cambio significativo.
Moderado	Uno o varios estresores relevantes sin colapso: dependencia creciente, sobrecarga leve-moderada persistente, malestar emocional subclínico, tensiones económicas o apoyo insuficiente.	Intervención psicoeducativa estructurada, individual o grupal, con seguimiento; resolución de problemas y manejo del estrés; reorganización de tareas familiares; articulación con trabajo social y redes comunitarias.	Contacto al menos mensual y nueva medición de sobrecarga a los tres meses.
Alto	Acumulación de predictores: síntomas depresivos o ansiosos, mala salud autopercibida, agotamiento, cuidado prolongado e intenso sin ayuda, problemas financieros, alta dependencia o síntomas conductuales marcados de la persona cuidada.	Valoración integral y plan individualizado; activación de salud mental; enfermería, trabajo social, apoyo comunitario y respiro; gestor del caso; visita domiciliaria si el cuidador no puede desplazarse.	Valoración ampliada en la siguiente visita según lineamiento PICF; seguimiento al menos quincenal hasta la estabilización; reevaluación mensual.
Crítico o de seguridad	Desborde severo con síntomas	Activación inmediata de rutas de urgencias,	Respuesta el mismo día; verificación de la

Nivel de riesgo	Criterios principales	Respuesta	Seguimiento mínimo de referencia
	conductuales graves, ausencia de relevo, deterioro rápido del cuidador o riesgo inminente de violencia, autolesión, abandono o negligencia.	salud mental, protección y respuesta social; plan inmediato de seguridad; alternativa temporal de cuidado; documentación objetiva.	recepción por el servicio en 72 horas; seguimiento semanal hasta superar la situación.

Fuente: Elaboración propia con base en las recomendaciones de esta pauta. Los intervalos de seguimiento corresponden a la orientación operativa por consenso del equipo técnico.

9.6 Pauta Pregunta 4. Estrategias de educación y apoyo para fortalecer la preparación, autoeficacia y competencia del cuidador

- Valoración educativa inicial

- Antes de iniciar una intervención educativa se recomienda valorar qué necesita aprender el cuidador, qué tareas realiza, qué conocimientos y habilidades posee, qué teme, qué dificultades enfrenta, cómo aprende mejor, qué recursos tiene disponibles y cuáles son sus condiciones de alfabetización en salud y acceso tecnológico.

- La educación debe partir de las necesidades reales del cuidador y de la persona cuidada. No se recomienda aplicar el mismo contenido a todas las familias sin considerar la enfermedad, dependencia, etapa del cuidado, experiencia previa y condiciones del hogar.

- Contenidos esenciales

- Se recomienda que la educación básica incluya: comprensión de la condición de salud; objetivos del cuidado; actividades cotidianas; reconocimiento de signos de alarma; medidas de prevención; uso de medicamentos y dispositivos; seguridad en casa; comunicación con los servicios; autocuidado; derechos; recursos disponibles y criterios para solicitar ayuda. Según la situación, este componente debe incluir material educativo específico sobre la condición de la

persona cuidada (por ejemplo, en demencia, la evolución de la enfermedad y el manejo de los síntomas conductuales y psicológicos); el reconocimiento de signos y síntomas de alteración en la salud mental del propio cuidador y de las rutas para buscar ayuda, y la prevención de lesiones del cuidador mediante mecánica corporal, técnicas seguras de movilización y levantamiento de cargas.

- En cuidadores responsables de medicamentos se recomienda incluir conciliación y organización de horarios, identificación de duplicidades o errores, conservación, administración segura, vigilancia de efectos adversos y criterios para consultar. El entrenamiento puede mejorar autoeficacia, confianza y preparación.

- En cuidadores que realizan transferencias o movilización se recomienda enseñar y practicar técnicas de posicionamiento, transferencia, marcha, uso de ayudas, prevención de caídas y protección corporal del cuidador. El entrenamiento debe ajustarse a la condición funcional de la persona cuidada y a las características físicas del hogar.

- En cuidadores de personas con deterioro cognitivo o síntomas conductuales se recomienda incluir comunicación, estructuración de rutinas, manejo no farmacológico de conductas, seguridad, prevención de deambulación riesgosa y estrategias para reducir el conflicto.

- Se recomienda incluir contenidos sobre autocuidado del cuidador, límites, descanso, alimentación, actividad física, manejo del estrés, reconocimiento de sobrecarga y solicitud temprana de apoyo. El autocuidado debe plantearse como condición para sostener el cuidado y no como responsabilidad exclusiva del cuidador frente a fallas de apoyo.

- La educación debe incluir información sobre servicios disponibles, apoyos sociales, respiro, trámites, beneficios, recursos financieros o legales y rutas de atención. Las intervenciones existentes abordan con menor frecuencia estos dominios, pese a su relevancia para prevenir sobrecarga y burnout.

- Métodos educativos

- Se recomienda utilizar estrategias activas: explicación, demostración, práctica supervisada, corrección de errores, resolución de casos, materiales de consulta y refuerzo posterior. La educación que desarrolla habilidades prácticas es más pertinente para la competencia del rol que la información pasiva.

- Se recomienda organizar la intervención en varias sesiones o contactos cuando la complejidad del cuidado lo requiera. Los programas con visitas domiciliarias, sesiones grupales y llamadas de seguimiento han mostrado mejorías en preparación, competencia y necesidades informativas.

- Las intervenciones multicomponente se recomiendan cuando se busca mejorar simultáneamente preparación, competencia, autoeficacia, afrontamiento y bienestar. Deben combinar educación con apoyo psicosocial, resolución de problemas y seguimiento.

- Cuando el cuidador tenga malestar emocional que interfiera con el aprendizaje o el desempeño del rol, se recomienda complementar la educación con apoyo psicológico, psicoeducación o intervención cognitivo-conductual. Enseñar tareas sin atender el distrés puede ser insuficiente. Se recomienda incluir en la psicoeducación la distribución de tareas y el establecimiento de roles de cuidado entre los integrantes de la familia, dado que el conflicto de rol y la ausencia de apoyo o relevo incrementan la sobrecarga.

- Se recomienda adaptar el lenguaje, la cantidad de información, los materiales, ejemplos y medios de entrega a la cultura, escolaridad, idioma, capacidades sensoriales y alfabetización en salud del cuidador. La comprensión no debe inferirse únicamente porque el cuidador asiente o recibe un folleto.

- Modalidades digitales, telefónicas y grupales

- Las intervenciones digitales pueden utilizarse para ofrecer educación, comunicación en tiempo real, apoyo, monitoreo y contacto con profesionales. Se recomienda priorizar herramientas sencillas, accesibles y vinculadas a un plan de seguimiento, en lugar de recursos digitales aislados.

- En cuidadores con acceso y habilidades digitales, se pueden emplear aplicaciones, plataformas web, videollamadas, mensajería o contenidos audiovisuales como complemento. Estas

intervenciones han mostrado beneficios en autoeficacia, habilidades de cuidado, apoyo social, afrontamiento y algunos desenlaces emocionales, aunque los resultados no son uniformes.

- Las intervenciones telefónicas o digitales no se recomiendan como única estrategia cuando el cuidador necesita entrenamiento físico, presenta alta sobrecarga, tiene dificultades cognitivas o de alfabetización, vive una crisis o requiere valoración de seguridad.

- Se recomienda ofrecer grupos de apoyo o espacios entre pares cuando sean aceptables y accesibles para el cuidador. Estos espacios pueden reducir aislamiento, facilitar intercambio de experiencias y fortalecer afrontamiento y apoyo social. Deben contar con objetivos, facilitación y mecanismos de remisión cuando se identifiquen necesidades clínicas o sociales.

- Transiciones y continuidad

- Antes del alta hospitalaria o del inicio de un nuevo cuidado en casa, se recomienda valorar la preparación del cuidador, enseñar las tareas necesarias, verificar disponibilidad de insumos y apoyos, entregar información sobre signos de alarma y establecer contactos para resolver dudas. La preparación insuficiente y la débil conexión entre servicios aumentan la inseguridad y afectan la continuidad del cuidado.

- Si el cuidador no demuestra competencia suficiente para una tarea de riesgo, se recomienda repetir el entrenamiento, simplificar el plan, involucrar otro cuidador o gestionar apoyo profesional. No debe asumirse que la familia puede realizar una tarea únicamente porque recibió información.

- La competencia se recomienda verificar mediante demostración de retorno: el cuidador realiza la tarea frente al profesional, preferiblemente en el hogar y con los insumos que usará, y explica con sus palabras los pasos, las precauciones y los signos de alarma. Se considera suficiente cuando ejecuta los pasos críticos sin errores que comprometan la seguridad y expresa confianza para hacerlo; el resultado debe registrarse con una lista de chequeo de la tarea.

- La educación debe reforzarse cuando cambie la condición de la persona cuidada, aparezcan nuevas tecnologías o medicamentos, se incremente la dependencia, se modifique la red de apoyo o el

cuidador manifieste inseguridad, y como mínimo en cada reevaluación programada según el nivel de riesgo.

- Evaluación de la intervención educativa

- Se recomienda evaluar los resultados educativos mediante cambios en preparación, autoeficacia, competencia, confianza, conocimientos, habilidades observadas, afrontamiento, sobrecarga y capacidad expresada para continuar cuidando. La asistencia a una sesión no debe considerarse por sí misma evidencia de aprendizaje.

- Para ello se recomienda registrar indicadores de proceso (proporción de cuidadores identificados, tamizados, clasificados y con plan de cuidado; sesiones o contactos realizados frente a los programados; remisiones con cierre de ciclo) e indicadores de resultado (cambio en el puntaje de sobrecarga con el mismo instrumento validado; cambio en preparación o autoeficacia; tareas de riesgo verificadas por demostración de retorno; síntomas emocionales; y capacidad expresada para continuar cuidando), medidos al inicio y en cada reevaluación programada.

- Si después de la intervención persisten inseguridad, errores, sobrecarga, síntomas emocionales o dificultades para continuar el cuidado, se recomienda intensificar el acompañamiento —aumentando la frecuencia de contactos al nivel de riesgo inmediatamente superior y reevaluando en un plazo no mayor de un mes— y revisar si el problema requiere entrenamiento adicional, apoyo psicosocial, relevo, gestión de casos o articulación con otros servicios.

- La sostenibilidad del cuidado en casa debe entenderse como resultado de la combinación entre un cuidador preparado, una distribución familiar viable, apoyos disponibles, atención oportuna y condiciones seguras. No se recomienda atribuir la sostenibilidad exclusivamente a la voluntad o capacidad individual del cuidador.

10. Referencias

1. Secretaria de Salud de Boyacá. Análisis de la situación de salud de la vigencia 2024. ASIS Boyacá 2024. Tunja; 2025.

2. Secretaria de salud de Boyacá. Análisis de la sitación de salud de la vigencia 2023. ASIS Boyacá 2023. Tunja; 2024.

3. Secretaria de Salud de Boyacá. Informe trimestral de indicadores SIBACOM. Tunja; 2025 Jul.

4. Secretaria de Salud de Boyacá. LINEAMIENTO TÉCNICO PICF 2025. 2025.

5. Addati L, Cattaneo U, Esquivel V, Valarino I. Care work and care jobs for the future of decent work [Internet]. Geneva; 2018 [cited 2026 Oct 14]. Available from: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_633135.pdf

6. Departamento Nacional de Planeación. DNP. Documento CONPES 4143. Política Nacional de Cuidado. Bogotá, D.C.; 2025.

7. International Labour Organization. Decent work and the care economy. Report VI, International Labour Conference. GENEVA; 2024.

8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. Santiago, Chile. ; 2022.

9. Bédard M, Molloy DW, Squire L, Dubois S, Lever JA, O'Donnell M. The Zarit Burden Interview. Gerontologist. 2001 Oct 1;41(5):652–7. doi:10.1093/geront/41.5.652

10. Soh XC, Hartanto A, Ling N, Reyes M, Sim L, Majeed NM. Prevalence of depression, anxiety, burden, burnout, and stress in informal caregivers: An umbrella review of meta-analyses. Archives of Gerontology and Geriatrics Plus. 2025 Sep;2(3):100197. doi:10.1016/j.aggp.2025.100197

11. Marx Y, Bauer A, Frese T, Unverzagt S. The challenge of identifying family carers in general practice at an early stage and measuring their burden: A scoping review of possible tools and their actual use. J Family Med Prim Care. 2024 Sep;13(9):3518–28. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_551_24

12. Loo YX, Yan S, Low LL. Caregiver burden and its prevalence, measurement scales, predictive factors and impact: A review with an Asian perspective. Singapore Medical Journal. Lippincott Williams and Wilkins; 2022. p. 593–603. doi:10.11622/smedj.2021033 PubMed PMID: 33866708.

13. Tu JY, Jin G, Chen JH, Chen YC. Caregiver Burden and Dementia: A Systematic Review of Self-Report Instruments. Journal of Alzheimer's Disease. IOS Press BV; 2022. p. 1527–43. doi:10.3233/JAD-215082

14. Riffin C, Wolff JL, Pillemer KA. Development and Evaluation of a Caregiver Checklist for Primary Care. Families, Systems and Health. 2024. doi:10.1037/fsh0000937 PubMed PMID: 39570699.

15. Poehler D, Giombi K, Shenkar E, Tayebali Z, Dempsey M, Khavjou O. Identifying and Measuring Caregiver Burdens: A Scoping Review. Population health management. 2026. p. 130–43. doi:10.1177/19427891251409802 PubMed PMID: 41661154.

16. Domeisen Benedetti F, Hechinger M, Fringer A. Self-Assessment Instruments for Supporting Family Caregivers: An Integrative Review. Healthcare (Switzerland). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI); 2024. doi:10.3390/healthcare12101016

17. Wangler J, Jansky M. Prerequisites for providing effective support to family caregivers within the primary care setting - results of a study series in Germany. BMC Fam Pract. 2021 Dec 22;22(1):252. doi:10.1186/s12875-021-01601-x PubMed PMID: 34937549.

18. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las dir. ectrices para su operación. Bogotá, Colombia.; 2018.

19. García-Rodríguez LC, Carreño-Moreno S, Chaparro-Díaz L. Instrumentos para la medición de sobrecarga del cuidador en pacientes con enfermedad crónica: revisión psicométrica. Salud UIS. 2022 Sep 16;55(1). doi:10.18273/saluduis.55.e:23005

20. Barreto-Osorio RV, Campos MS, Carrillo-González GM, Coral-Ibarra R, Chaparro-Díaz L, Duran Parra M, et al. Entrevista Percepción de Carga del Cuidado de Zarit: pruebas psicométricas para Colombia. Aquichan. 2015 Sep 1;15(3):368–80. doi:10.5294/aqui.2015.15.3.5

21. del-Pino-Casado R, Priego-Cubero E, López-Martínez C, Orgeta V. Subjective caregiver burden and anxiety in informal caregivers: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. Public Library of Science; 2021. doi:10.1371/journal.pone.0247143 PubMed PMID: 33647035.

22. Chen Y, Yi S, Chen R, Zhang Q. The efficacy of psychosocial interventions in relieving family caregiver burden in older adults with disabilities: A systematic review and network meta-analysis. Age Ageing. 2025 Jun 1;54(6). doi:10.1093/ageing/afaf155 PubMed PMID: 40499128.

23. González-Fraile E, Ballesteros J, Rueda JR, Santos-Zorrozúa B, Solà I, McCleery J. Remotely delivered information, training and support for informal caregivers of people with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2021. doi:10.1002/14651858.CD006440.pub3 PubMed PMID: 33417236.

24. Jaffray L, Bridgman H, Stephens M, Skinner T. Evaluating the effects of mindfulness-based interventions for informal palliative caregivers: A systematic literature review. Palliative Medicine. SAGE Publications Ltd; 2016. p. 117–31. doi:10.1177/0269216315600331 PubMed PMID: 26281853.

25. Boele FW, Rooney AG, Bulbeck H, Sherwood P. Interventions to help support caregivers of people with a brain or spinal cord tumour. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2019. doi:10.1002/14651858.cd012582.pub2 PubMed PMID: 31264707.

26. Domingues NS, Verreault P, Hudon C. Reducing Burden for Caregivers of Older Adults With Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review. American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias. SAGE Publications Inc.; 2018. p. 401–14. doi:10.1177/1533317518788151 PubMed PMID: 30041535.

27. Liu F, Zhang H, Li S, Wang X, Long X, Liu Y. Interventions for reducing caregiver burden in chronic dyspnea: a meta-analysis. Frontiers in Public Health. Frontiers Media SA; 2025. doi:10.3389/fpubh.2025.1659063 PubMed PMID: 41179764.

28. Córdoba AMC, Osma LJP, Vargas CJG, Mantilla MSQ, Peña AJP, Amaya WAÁ. Interventions for informal caregivers of patients with Major Neurocognitive Disorder: a review from transdisciplinarity. Interdisciplinaria. 2022;39(2):313–34. doi:10.16888/interd.2022.39.2.20

29. Surer HK, Yaylagul NK, Helvik AS. Psychosocial Interventions to Reduce Caregiver Burden in Family Caregivers of People With Dementia: A Systematic Review. Geriatrics and Gerontology International. John Wiley and Sons Inc; 2025. p. 1693–723. doi:10.1111/ggi.70190 PubMed PMID: 41162317.

30. Martinez VM, Ormel H, op de Coul ELM. Barriers and enablers that influence the uptake of HIV testing among heterosexual migrants in the Netherlands. PLoS One. 2024;19(10). doi:10.1371/journal.pone.0311114 PubMed PMID: WOS:001336858900034.

31. Vázquez FL, Blanco V, Hermida E, Otero P, Torres Á, Díaz-Fernández O. Eficacia de las intervenciones psicológicas breves para reducir los síntomas depresivos en cuidadores: Revisión sistemática y meta-análisis. Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica. 2015 Dec 1;20(3):173–88. doi:10.5944/rppc.vol.20.num.3.2015.15891

32. Jadalla A, Page M, Ginex PA, Coleman M, Vrabel M, Bevans M. Family caregiver strain and burden a systematic review of evidence-based interventions when caring for patients with cancer. Clin J Oncol Nurs. 2020 Feb 1;24(1):31–50. doi:10.1188/20.CJON.31-50 PubMed PMID: 31961843.

33. Egan KJ, Pinto A, Bighelli I, Berg-Weger M, Van Straten A, Albanese E, et al. Online Training and Support Programs Designed to Improve Mental Health and Reduce Burden Among Caregivers of People With Dementia: A Systematic Review.

34. Cardoso C, Lumini MJ, Martins T. Effects of physical exercise in reducing caregivers burden: a systematic review. Frontiers in Public Health. Frontiers Media SA; 2025. doi:10.3389/fpubh.2025.1474913 PubMed PMID: 39975791.

35. Camarena JMT, Blanco MÀH, Sansano ND, Lluch MT, Aran LRL, Llobet MP. Nursing interventions to reduce the overload on informal caregivers. Systematic review of clinical trials. Enfermeria Global. 2022 Oct 1;21(4):575–86. doi:10.6018/eglobal.502351

36. Brito Cárdenes S. Efectividad de las intervenciones enfermeras en la sobrecarga del cuidador familiar del adulto mayor dependiente. Conocimiento Enfermero. 2025 May 19;8(28):52–68. doi:10.60108/ce.371

37. Li J, Alavi K, Shaari AAH. Primary and Secondary Stressors Affecting Family Caregiver Burden for Disabled Older Adults: A Systematic Review. Health and Social Care in the Community. John Wiley and Sons Ltd; 2025. doi:10.1155/hsc/5109659

38. Lindt N, Van Berkel J, Mulder BC. Determinants of overburdening among informal carers: A systematic review. BMC Geriatr. 2020 Aug 26;20(1). doi:10.1186/s12877-020-01708-3 PubMed PMID: 32847493.

39. Feast A, Moniz-Cook E, Stoner C, Charlesworth G, Orrell M. A systematic review of the relationship between behavioral and psychological symptoms (BPSD) and caregiver well-being. International Psychogeriatrics. Cambridge University Press; 2016. p. 1761–74. doi:10.1017/S1041610216000922 PubMed PMID: 27345942.

40. Isac C, Lee P, Arulappan J. Older adults with chronic illness – Caregiver burden in the Asian context: A systematic review. Patient Education and Counseling. Elsevier Ireland Ltd; 2021. p. 2912–21. doi:10.1016/j.pec.2021.04.021 PubMed PMID: 33958255.

41. Amer Nordin A, Mohd Hairi F, Choo WY, Hairi NN. Care Recipient Multimorbidity and Health Impacts on Informal Caregivers: A Systematic Review. Gerontologist. Gerontological Society of America; 2019. p. e611–28. doi:10.1093/geront/gny072 PubMed PMID: 29982539.

42. Yuen E, Wilson C, Adams J, Kangutkar T, Livingston PM, White VM, et al. Health literacy interventions for informal caregivers: systematic review. BMJ Supportive and Palliative Care. BMJ Publishing Group; 2025. p. 300–18. doi:10.1136/spcare-2023-004513 PubMed PMID: 38326015.

43. Saucedo-Pahua G, Caetano G, Jiménez-González M, Fhon J. Home-based educational interventions for family caregivers of older adults after stroke: a scoping review. REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP. 2024 Jun. doi:10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0339en

44. Chi NC, Demiris G, Lewis FM, Walker AJ, Langer SL. Behavioral and Educational Interventions to Support Family Caregivers in End-of-Life Care. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2016 Nov 11;33(9):894–908. doi:10.1177/1049909115593938

45. Hudson PL, Aranda S, Hayman-White K. A Psycho-Educational Intervention for Family Caregivers of Patients Receiving Palliative Care: A Randomized Controlled Trial. J Pain Symptom Manage. 2005 Oct;30(4):329–41. doi:10.1016/j.jpainsymman.2005.04.006

46. Wagle KC, Skopelja EN, Campbell NL. Caregiver-Based Interventions to Optimize Medication Safety in Vulnerable Elderly Adults: A Systematic Evidence-Based Review. Journal of the American Geriatrics Society. Blackwell Publishing Inc.; 2018. p. 2128–35. doi:10.1111/jgs.15556 PubMed PMID: 30136714.

47. Weir RL, Danilovich MK, Hoover DL. Systematic review of the effectiveness of caregiver training with functional mobility tasks for

informal caregivers assisting patients with neurological diagnoses. Disability and Rehabilitation. Taylor and Francis Ltd.; 2022. p. 5082–9. doi:10.1080/09638288.2021.1923073 PubMed PMID: 34167399.

48. Zhai S, Chu F, Tan M, Chi NC, Ward T, Yuwen W. Digital health interventions to support family caregivers: An updated systematic review. Digital Health. SAGE Publications Inc.; 2023. doi:10.1177/20552076231171967

49. Yu Y, Xiao L, Ullah S, Meyer C, Wang J, Pot AM, et al. The effectiveness of internet-based psychoeducation programs for caregivers of people living with dementia: a systematic review and meta-analysis. Aging and Mental Health. Routledge; 2023. p. 1895–911. doi:10.1080/13607863.2023.2190082 PubMed PMID: 36951611.

50. Corry M, Neenan K, Brabyn S, Sheaf G, Smith V. Telephone interventions, delivered by healthcare professionals, for providing education and psychosocial support for informal caregivers of adults with diagnosed illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2019. doi:10.1002/14651858.CD012533.pub2 PubMed PMID: 31087641.

51. Sulino-Gonçalves MC, Lima RAG de, Jardim FA, Okido ACC, Cassemiro LKD da S, Nascimento LC, et al. Social support for family caregivers of children and youth with special health care needs for home care: a scoping review. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2025;59. doi:10.1590/1980-220x-reeusp-2024-0368en

11. Anexos

11.1 Ecuaciones de búsqueda

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD sugerida	Términos clave sugeridos	Ecuación de búsqueda preliminar
¿Qué estrategias e instrumentos validados se usan para identificar la sobrecarda del cuidador y riesgos del cuidador en el entorno hogar y clasificarlos para decidir intensidad de acompañamiento?	Evaluación / clasificación de riesgo	P: cuidadores familiares en entorno hogar, especialmente de personas con dependencia, discapacidad, enfermedad crónica o fragilidad. I: instrumentos y estrategias validadas para identificar rol cuidador, carga, riesgo físico, mental y social. C: otra herramienta, atención usual o ausencia de valoración estructurada. O: identificación y clasificación del riesgo, definición de intensidad de acompañamiento, factibilidad y utilidad clínica.	caregiver, family caregiver, informal caregiver, caregiver burden, caregiver role, home care, household, primary health care, risk assessment, screening, Zarit, caregiver strain, social support, mental health, physical health	("Caregivers" OR caregiver* OR "family caregiver*" OR "informal caregiver*") AND (home OR household OR "home care" OR "entorno hogar") AND ("Primary Health Care" OR "primary care" OR "atención primaria") AND ("Risk Assessment" OR screening OR stratification OR "caregiver burden" OR "caregiver role" OR "caregiver strain" OR Zarit OR "validated instrument*" OR questionnaire*) AND (guideline* OR "practice guideline" OR "systematic review" OR consensus)

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD sugerida	Términos clave sugeridos	Ecuación de búsqueda preliminar
				Pubmed: Caregiving Burden Scale;

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD sugerida	Términos clave sugeridos	Ecuación de búsqueda preliminar
En cuidadores familiares de personas ¿qué intervenciones estructuradas dirigidas al cuidador, mejoran su salud y favorecen la sostenibilidad del cuidado en el entorno hogar?	Intervención / efectividad	P: cuidadores familiares en entorno hogar. I: intervenciones de apoyo, autocuidado, respiro, educación, apoyo psicológico, ejercicio, entrenamiento en cuidado, apoyo social o multicomponente. C: atención usual, no intervención u otra intervención. O: menor sobrecarga, menor ansiedad/depresión, mejor salud física, mejor calidad de vida, mayor capacidad de cuidado y sostenibilidad del rol.	caregiver intervention, respite care, psychoeducation, support group, counseling, multicomponent intervention, self-care, physical exercise, mental health, quality of life, sustainability of care	("Caregivers" OR caregiver* OR "family caregiver*" OR "informal caregiver*") AND (home OR household OR "home care" OR "entorno hogar") AND (intervention* OR program* OR psychoeducation OR counseling OR "support group*" OR "respite care" OR exercise OR training OR "self-care" OR "multicomponent intervention*") AND (effectiveness OR efficacy OR "quality of life" OR burden OR depression OR anxiety OR "mental health" OR "physical health" OR sustainability) AND (guideline* OR "systematic review" OR meta-analysis OR consensus)

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD sugerida	Términos clave sugeridos	Ecuación de búsqueda preliminar
En cuidadores familiares o informales de personas de la familia con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿qué signos de alarma y criterios clínicos, psicosociales y de seguridad permiten identificar riesgo de deterioro de la salud mental o física, violencia y colapso del rol cuidador, y qué respuestas intersectoriales deben activarse según el nivel de riesgo para proteger al cuidador y sostener el cuidado en casa?	Componente A. Identificación y estratificación del riesgo En cuidadores familiares o informales de personas de la familia con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿qué signos de alarma y criterios clínicos, psicosociales y de seguridad permiten identificar y estratificar riesgo de deterioro de la salud mental o física, violencia y colapso del rol cuidador? Componente B. Respuesta y activación intersectorial En cuidadores familiares o informales con signos de alarma o alto riesgo en el entorno hogar, ¿qué	P: cuidadores familiares en entorno hogar. I: criterios de alarma, detección temprana, activación de redes sanitarias, sociales y de protección. C: ausencia de criterios o manejo habitual. O: identificación oportuna de riesgo, remisión y activación efectiva, continuidad del cuidado, prevención de daño o colapso del rol.	caregiver red flags, warning signs, caregiver distress, burnout, abuse, violence, mental health risk, referral, social support services, intersectoral response, care coordination	("Caregivers" OR caregiver* OR "family caregiver*" OR "informal caregiver*") AND (home OR household OR "entorno hogar") AND ("warning signs" OR "red flags" OR distress OR burnout OR violence OR abuse OR "mental health risk" OR "physical health risk" OR "role strain") AND (referral OR "care coordination" OR "social support services" OR intersectoral OR "community network*" OR "protective services") AND ("Primary Health Care" OR "primary care") AND (guideline* OR "systematic review" OR protocol* OR consensus) Pubmed: Caregiving Burden Scale;

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD sugerida	Términos clave sugeridos	Ecuación de búsqueda preliminar
	respuestas y mecanismos de articulación intersectorial deben activarse, según el nivel de riesgo, para proteger al cuidador y sostener el cuidado en casa?			

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD sugerida	Términos clave sugeridos	Ecuación de búsqueda preliminar
En cuidadores familiares o informales de personas de la familia con necesidades de cuidado en el entorno hogar, ¿qué estrategias estructuradas de educación y apoyo dirigidas al cuidador mejoran la preparación, la autoeficacia y la competencia para ejercer el rol cuidador y favorecen la sostenibilidad del cuidado en casa?	Educación / apoyo / implementación	P: cuidadores familiares en entorno hogar. I: educación para el cuidado, apoyo emocional, entrenamiento práctico, acompañamiento en visitas, apoyo entre pares, materiales educativos, fortalecimiento de redes. C: apoyo habitual, no estructurado o ausencia de intervención. O: competencias de cuidado, autoeficacia, adherencia, bienestar del cuidador, mejor desempeño del rol y continuidad del cuidado.	caregiver education, caregiver training, caregiver support, self-efficacy, competence, home visits, peer support, family support, community networks, empowerment	("Caregivers" OR caregiver* OR "family caregiver*" OR "informal caregiver*") AND (home OR household OR "home visit*" OR "entorno hogar") AND (education OR training OR support OR counseling OR "peer support" OR empowerment OR "self-efficacy" OR competence OR "family support") AND (adherence OR wellbeing OR "role performance" OR "continuity of care" OR implementation) AND (guideline* OR "systematic review" OR consensus OR "best practice")